Examensarbete i omvårdnad, 15 hp

Ett annat sätt att fungera -

Vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD

-En integrativ litteraturstudie

Ulrika Ahl
Rebecca Folkesson

Handledare: Johanna Tell
Specialistsjuksköterskeprogrammet, kurs: OM2557
Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa
Karlskrona augusti 2026

Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa
Specialistsjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad
Augusti 2026

Ett annat sätt att fungera - Vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD

-En integrativ litteraturstudie

Ulrika Ahl
Rebecca Folkesson

Sammanfattning
Bakgrund: Att leva med ADHD som vuxen innebär ofta ett dolt, tyst lidande präglat av livslång kritik, missförstånd och utmattande social maskering. Den konstanta anpassningen till neurotypiska normer riskerar att försämra den psykiska hälsan. Det finns därför ett behov av ökad kunskap inom psykiatrisk omvårdnad för att förstå hur dessa individer kan stöttas över livsloppet. Vuxnas egna subjektiva erfarenheter är idag fragmenterade och otillräckligt sammanställda i sin helhet.
Syfte: Syftet med studien var att sammanställa vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD.
Metod: En integrativ litteraturstudie med en abduktiv ansats, baserad på nio artiklar med varierande design, genomfördes i enlighet med Whittemore & Knafl (2005) metod. Sökningar gjordes i två databaser och inkluderade kvalitetsgranskade studier om vuxnas (≥18 år) erfarenheter av att leva med ADHD. Analysprocessen genomfördes iterativt i fyra faser. Processen påbörjades induktivt genom en förutsättningslös kodning av rådata, för att i slutskedet övergå i en deduktiv tematisering där KASAM användes som teoretiskt ramverk.
Resultat: Analysen resulterade i tre huvudteman baserade på KASAM-modellens komponenter. *Att förstå sig själv och sin historia* (begriplighet*), Att upprätthålla funktion genom reglering och kompensation* (hanterbarhet) samt *Att bevara sig själv i förändring* (meningsfullhet), vilka presenteras med vardera två underteman. Tiden före diagnos präglades av internaliserad kritik och en sårad självbild. Diagnosen utgjorde en vändpunkt som skapade begriplighet. Vardagen gjordes hanterbar genom inre reglering och yttre stödstrukturer, men strategierna utmanades vid livsförändringar och maskering ledde till emotionell dränering. Meningsfullhet framträdde när individerna fann acceptans, identifierade egna resurser och formade livet utifrån egna villkor.
Slutsats: Erfarenheten av att leva med ADHD formas i ett komplext samspel mellan individen och omgivningen. En hållbar hanterbarhet i vardagen försvåras om den enbart vilar på ständig självkontroll och maskering. Specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk omvårdnad har en central funktion i att arbeta proaktivt och personcentrerat för att stärka individens begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, särskilt under sårbara livsövergångar.

Nyckelord: *ADHD, integrativ litteraturstudie, KASAM, levda erfarenheter, omvårdnad, vuxna*

Blekinge Institute of Technology, Department of Health
Specialist Nursing Programme, Degree Project in Nursing
August 2026

A Different Way of Functioning - Adults' Experiences of Living with ADHD
-An Integrative literature review

Ulrika Ahl
Rebecca Folkesson

Abstract
Background: Living with ADHD in adulthood often entails hidden, silent suffering characterized by lifelong criticism, misunderstandings, and exhausting social masking. This constant adaptation to neurotypical norms risks deteriorating mental health. Consequently, there is a need for increased knowledge within psychiatric nursing to understand how these individuals can be supported throughout the life course. Adults' own subjective experiences remain fragmented and insufficiently compiled in their entirety.
Aim: The aim of this study was to synthesize adults' experiences of living with ADHD.
Method: An integrative literature review with an abductive approach, based on nine articles of varying designs, was conducted in accordance with Whittemore & Knafl (2005) framework. Searches were performed in two databases and included quality-appraised studies focusing on the experiences of adults (≥18 years) living with ADHD. The analysis process was carried out iteratively across four phases. The study applied an abductive approach where the process initiated inductively through open coding of the raw data, and in the final stage transitioned into a deductive thematization where the Sense of Coherence (SOC) model was utilized as the theoretical framework.
Results: The analysis resulted in three main themes based on the components of the SOC model: *Understanding oneself and one's history* (comprehensibility), *Maintaining function through regulation and compensation* (manageability), and *Preserving oneself through change* (meaningfulness), each presented with two subthemes. The period prior to diagnosis was characterized by internalized criticism and a wounded self-image. The diagnosis constituted a turning point that created comprehensibility. Daily life was made manageable through internal regulation and external support structures, but these strategies were challenged during life transitions, and masking led to emotional depletion. Meaningfulness emerged when individuals found acceptance, identified their own resources, and shaped their lives on their own terms.
Conclusion: The experience of living with ADHD is shaped by a complex interaction between the individual and their environment. Sustainable manageability in daily life is hindered if it relies solely on continuous self-control and masking. The psychiatric nurse specialist plays a pivotal role in working proactively and person-centered to strengthen the individual's comprehensibility, manageability, and meaningfulness, particularly during vulnerable life transitions.
Keywords: *ADHD, adults, integrative literature review, lived experiences, nursing, sense of coherence*

Förord

Vi vill tacka varandra för gott samarbete, tålamod och många skratt, särskilt under de stunder då metodens komplexitet gjort sig extra påmind.
Tack till våra familjer för stöd och förståelse, samt för att ha hållit vardagen fungerande medan vi varit uppslukade av analyser och omtag.

Innehållsförteckning

Inledning ... 7

Bakgrund ... 7

Historik ... 7

Etiologi, symtom och epidemiologi ... 8

Tidigare forskning om ADHD hos vuxna ... 9

Omvårdnadsperspektivet ... 9

Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk omvårdnad ... 10

Teoretiskt ramverk ... 11

Problemformulering ... 12

Syfte ... 12

Metod ... 12

Design ... 12

Litteratursökning ... 15

Datautvärdering ... 16

Dataanalys ... 17

Datareduktion och datavisualisering ... 18

Datajämförelse ... 19

Dataverifiering och slutsats ... 20

Etiska överväganden ... 20

Resultat ... 21

Tema 1. Att förstå sig själv och sin historia ... 22

1.1 Erfarenheter av en sårad självbild ... 22

1.2 Förstå sina erfarenheter i ljuset av ADHD ... 23

Tema 2. Att upprätthålla funktion genom reglering och kompensation ... 24

2.1. Att reglera inre belastning ... 24

2.2 Skapa yttre strukturer ... 25

Tema 3. Att bevara sig själv i förändring ... 26

3.1. Att identifiera resurser i det egna sättet att fungera ... 26

3.2. Att forma ett hållbart liv utifrån egna villkor ... 27

Diskussion 28
Metoddiskussion 28
Resultatdiskussion 31
Klinisk tillämpning 34
Framtida forskning 36
Självständighet 37
Referenslista 39
Bilaga 1a. Databassökning i CINAHL. 44
Bilaga 1b. Databassökning i PubMed. 45
Bilaga 2. Flödesschema. 46
Bilaga 3. Matris för kvalitetsgranskning av artiklar. 47
Bilaga 4. Granskningsmall. 49
Bilaga 5. Artikelöversikt. 50
Bilaga 6. Jämförelsematris. 52

Inledning

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) hos vuxna har ökat under senare år, men kunskapen om hur det är att leva med ADHD i vardagen är fortfarande fragmenterad. Tidigare studier har främst fokuserat på symtom, funktionsnedsättning och behandling, medan vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD och hantera vardagens utmaningar har fått mindre uppmärksamhet. Detta gör förståelsen av ADHD splittrad, trots att tillståndet påverkar livet på flera övergripande nivåer (Ginapp et al., 2022; Rosenthal et al., 2025).

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innebär en god hälsa med vård på lika villkor för alla. Vården ska ges med respekt och värdighet för människors lika värde (HSL, 2017). Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskan i psykiatri tydliggör expertisen inom den psykiatriska omvårdnaden. Alla har rätt till att uppleva hälsa utifrån sina förutsättningar samt få individuellt anpassat stöd när behov föreligger. Specialistsjuksköterskan i psykiatri besitter kompetens rörande komplexa samband mellan psykisk och fysisk hälsa samt dess påverkan av sociala, existentiella och kulturella faktorer (Svensk sjuksköterskeförening, 2024).

En sammanställning av de senaste årens forskning kan ge en fördjupad förståelse för vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD vilket kan ha betydelse för den psykiatriska omvårdnaden där behov och livssituation utgör grunden för personcentrerade insatser.

Bakgrund

Historik

Beskrivningar av beteenden som i dag förknippas med ADHD finns dokumenterade sedan 1750 - talet (Faraone et al., 2021; Lange et al., 2010). Under 1940- och 1950-talet förklarades koncentrationssvårigheter och impulsivitet främst utifrån bristande uppväxtförhållanden och relationella faktorer (Carlberg, 2014; Lange et al., 2010). Synen på ADHD har varierat över tid i takt med samhällsutveckling och forskning. Tillståndet förstås i dag som ett komplext biopsykosocialt tillstånd där biologiska, psykologiska och sociala faktorer samverkar över livsloppet (Carlberg, 2014; Faraone et al., 2021).

Etiologi, symtom och epidemiologi

ADHD har en stark genetisk komponent. Herediteten är cirka 80 %. Neurobiologiska skillnader i hjärnans struktur och funktion ses. Särskilt påverkas nätverk som reglerar exekutiva funktioner såsom planering, arbetsminne och självstyrning, vilka utvecklas och förändras i samspel med ålder och omgivning (Cortese et al., 2025). Obalans i signalsubstanserna dopamin och noradrenalin kan bidra till svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll, motivation och vardaglig funktion (Cortese et al., 2025; Faraone et al., 2021).

Kärnsymtomen omfattar hyperaktivitet, impulsivitet och/eller ouppmärksamhet. Exekutiva svårigheter kan påverka förmågan att organisera, reglera aktivitet och beteende, planera långsiktigt samt uppfatta tid. Det kan leda till konsekvenser i vardagen och i livet. Personer med ADHD uppvisar individuella variationer samt presterar ojämnt (Socialstyrelsen, 2019).

Prevalensen i Sverige uppskattas till cirka 5–7 % bland barn och ungdomar samt omkring 3 % bland vuxna. Globalt uppskattas prevalensen hos vuxna till cirka 2,5 %. Omkring 70 % av de individer som diagnostiseras i barndomen har kvarstående symtom i vuxen ålder (Cortese et al., 2025; Faraone et al., 2021; Region Stockholm, 2025).

Diagnostik och behandling

Utredning av ADHD omfattar vanligtvis medicinsk bedömning, psykologisk testning och strukturerade intervjuer (Riksförbundet Attention, 2026). För diagnos krävs ett ihållande mönster av ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet-impulsivitet som debuterat före 12 års ålder, förekommer i minst två miljöer och medför en funktionsnedsättning i vardagen (Faraone et al., 2021). ADHD klassificeras utifrån svårighetsgrad och symtombild som kombinerad form, huvudsakligen ouppmärksam form eller huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form (Region Stockholm, u.å.).

Kvinnor diagnostiseras ofta senare än män, vilket delvis kan förklaras av att symtomen i högre grad yttrar sig som ouppmärksamhet än utagerande beteenden (Skoglund et al., 2024). Både barn och vuxna diagnostiseras utifrån samma diagnoskriterier och Cortese et al. (2025) framhåller att ADHD-symtom förändras över livsloppet och ofta uttrycks annorlunda hos vuxna än hos barn, vilket innebär att diagnostiken behöver anpassas till vuxnas symtombild och funktionsnedsättning. Behandlingen är individanpassad och kan omfatta farmakologiska, psykosociala och pedagogiska insatser för att minska symtom och stärka funktionsförmågan

(Carlberg, 2014; Socialstyrelsen, 2019). Eftersom ADHD ofta kvarstår genom livet finns ett långsiktigt behov av vård och stöd (Cortese et al., 2025; Faraone et al., 2021).

Tidigare forskning om ADHD hos vuxna

ADHD i vuxenlivet är förknippat med svårigheter inom bland annat utbildning, arbete, relationer och vardagsfungerande (Cortese et al., 2025; Faraone et al., 2021). Vuxna med ADHD beskriver även nedsatt förmåga att planera, organisera och reglera känslor och beteenden, vilket kan få konsekvenser för livskvalitet och funktion (Bjerrum et al., 2017; Redshaw & McCormack, 2022).

ADHD är associerat med ökad risk för psykisk och somatisk samsjuklighet, substansbruk samt sociala och ekonomiska svårigheter (Cortese et al., 2025; Faraone et al., 2021; Ginapp et al., 2022; Rosenthal et al., 2025). Stigma, bristande förståelse och negativa erfarenheter i mötet med omgivningen och vården kan dessutom begränsa välbefinnandet och delaktighet (Ginapp et al., 2022; Tal et al., 2023; Watters et al., 2018).

Samtidigt beskriver personer med ADHD både styrkor och resurser, vilket belyser behovet av ett bredare perspektiv på tillståndet (Redshaw & McCormack, 2022; Rosenthal et al., 2025).

Trots en växande kunskapsbas är forskningen fortfarande fragmenterad och fokuserar ofta på enskilda aspekter av att leva med ADHD snarare än den samlade levda erfarenheten (Ginapp et al., 2022; Rosenthal et al., 2025; Ward et al., 2024). Nya prognoser visar en fortsatt global ökning av diagnosticerad ADHD, i synnerhet bland vuxna kvinnor, vilket ställer krav på riktade, evidensbaserade omvårdnadsinsatser för att lindra individens lidande och dämpa tillståndets långvariga socioekonomiska påverkan på samhällsnivå (Wang et al., 2025).

Omvårdnadsperspektivet

Omvårdnad vilar på en humanvetenskaplig grund där patientens levda erfarenheter och individuella vårdbehov utgör utgångspunkten för förståelsen av hälsa och ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2024; Wiklund Gustin, 2024). Kunskap om hur ADHD påverkar vardag, relationer och välbefinnande är därför central inom psykiatrisk omvårdnad (Ryttersund et al., 2020). Ett personcentrerat förhållningssätt innebär att vården utgår från individens erfarenheter, resurser och behov snarare än enbart diagnosen, vilket kan stärka

autonomi, delaktighet och återhämtning (Ryttersund et al., 2020; Svensk sjuksköterskeförening, 2024). En terapeutisk relation som präglas av tillit, respekt och kontinuitet är en viktig komponent i omvårdnaden (Ryttersund et al., 2020; Wangel et al., 2024). Kommunikation, lyhördhet, empati och ett icke dömande bemötande bidrar till att skapa förtroende och främja hälsa hos personer med psykisk ohälsa (Kwame & Petrucka, 2021; Wangel et al., 2024).

Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk omvårdnad

Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk omvårdnad har ett självständigt ansvar för att bedriva en säker, etisk och personcentrerad vård som främjar delaktighet, återhämtning och psykisk hälsa. Specialistsjuksköterskan i psykiatri har en nyckelfunktion i att öka förståelsen för hur långvariga tillstånd, såsom ADHD, påverkar individens funktion och dagliga livsföring. Genom att identifiera individuella behov, resurser och specifika barriärer kan omvårdnadsinsatser planeras och anpassas utifrån personens individuella unika livssituation (Ryttersund et al., 2020). Specialistsjuksköterskan stöttar individen genom att erbjuda struktur, kontinuitet och konkreta strategier för att hantera vardagliga utmaningar, samt genom att systematiskt följa upp hur insatserna fungerar över tid (Ward et al., 2024).

Ett återhämtningsinriktat arbetssätt utgår konsekvent från individens egna mål, resurser och möjligheter till ett meningsfullt liv trots psykisk ohälsa. Specialistsjuksköterskan bär därför ett väsentligt ansvar för att stärka individens delaktighet, självbestämmande och inger hopp om framtiden (Wangel et al., 2024; Wiklund Gustin, 2024). Genom att uppmärksamma och kartlägga personens erfarenheter och livssituation bidrar omvårdnaden till ökad begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i återhämtningsprocessen (Antonovsky, 2005).

Samverkan med närstående och andra professioner är en integrerad del av den psykiatriska omvårdnaden och bidrar till en sammanhållen och individanpassad vårdkedja. Genom samordning mellan olika vårdaktörer kan stödinsatser struktureras utifrån individens sammansatta behov och förutsättningar, vilket främjar långsiktig hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2024; Ward et al., 2024). För att detta ska vara kliniskt genomförbart behöver specialistsjuksköterskan dock ges organisatoriska förutsättningar att avsätta tid för det relationsskapande arbetet, den personcentrerade omvårdnaden och den kontinuerliga uppföljningen, utöver de medicinska och administrativa insatserna (Wangel et al., 2024).

Teoretiskt ramverk

Som teoretiskt ramverk användes Antonovskys (2005) modell om känsla av sammanhang (KASAM). Ramverket har en direkt relevans för att belysa hur vuxna personer med ADHD erfar och navigerar de utmaningar som uppstår inom skilda livsområden i vardagen. Ramverket utgår från ett salutogent perspektiv, vilket innebär att fokus skiftas från sjukdom och patologi till de faktorer som främjar hälsa, resurser och välbefinnande. Enligt detta synsätt kan en individ uppleva ett starkt KASAM trots påtagliga externa påfrestningar och livsutmaningar. KASAM består av de tre sammanflätade komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa begrepp beskriver i vilken utsträckning individen upplever tillvaron som strukturerad, hanterbar och meningsbärande, vilket betraktas som avgörande för att bevara och återvinna hälsa (Antonovsky, 2005).

Begriplighet avser i vilken grad en person upplever att händelser, situationer och information i omgivningen är begripliga, organiserade och förutsägbara. En hög grad av begriplighet innebär att individen kognitivt kan strukturera det som sker samt se tydliga samband mellan orsaker och konsekvenser. Den andra komponenten, hanterbarhet, handlar om individens upplevelse av att förfoga över tillräckliga resurser för att möta livets krav och påfrestningar. Dessa resurser kan vara såväl interna, i form av egna förmågor och erfarenheter, som externa, såsom socialt och professionellt stöd från omgivningen. Den tredje komponenten, meningsfullhet, avser den emotionella dimensionen och i vilken grad individen upplever engagemang, motivation och syfte. Meningsfullhet innebär att livets utmaningar och motgångar uppfattas som värda att investera tid, energi och personligt engagemang i. Individer med en hög grad av upplevd meningsfullhet tenderar att betrakta svårigheter som hanterbara utmaningar, medan en låg grad av meningsfullhet oftare genererar känslor av maktlöshet och en sårbarhet för att ge upp vid motgångar (Antonovsky, 2005).

Att applicera KASAM i en psykiatrisk omvårdnadskontext bidrar till en fördjupad förståelse för hur personer med ADHD upplever sin livssituation. Ramverket möjliggör en systematisk och teoretiskt förankrad tolkning av hur vuxna med ADHD hanterar vardagliga krav, samt hur deras känsla av sammanhang samverkar med funktion och psykiskt välbefinnande. Det ger därmed ett teoretiskt stöd för att tolka hur vuxna med ADHD skapar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sina levda erfarenheter. Genom att synliggöra dessa processer kan omvårdnaden identifiera vilka specifika behov individen har för att främja en stark känsla av sammanhang, vilket i sin tur stärker individens motståndskraft i mötet med livets utmaningar

(Antonovsky, 2005).

Problemformulering

Vuxna med ADHD beskriver erfarenheter av att inte passa in, inte fungera eller prestera som andra samt en känsla av stigmatisering i mötet med omgivningen. Tillståndet genererar påtagliga utmaningar i det dagliga livet och flätas samman med svårigheter rörande social delaktighet och psykiskt välbefinnande vilket begränsar individens livskvalitet och möjligheter till ett fungerande vardagsliv (Bangma et al., 2019; Koerts et al., 2023). Samtidigt utgör ADHD ett omfattande globalt hälsoproblem med betydande variationer i prevalens och uttrycksformer beroende på region, sociodemografisk tillhörighet och kön.

Denna brist på en sammanvägd och integrerad förståelse begränsar hälso- och sjukvårdens möjligheter att utveckla personcentrerade insatser utifrån patienters levda erfarenheter och sammansatta livsvärld (Ginapp et al., 2022; Rosenthal et al., 2025; Ward et al., 2024) För specialistsjuksköterskan i psykiatrisk omvårdnad är kunskap om patienters subjektiva upplevelser central för att kunna erbjuda en god, säker och personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2024; Wiklund Gustin, 2024).

Genom att sammanställa och integrera forskning om vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD kan en mer heltäckande förståelse utvecklas (Whittemore & Knafl, 2005). En sådan syntes kan bidra till ett vetenskapligt kunskapsunderlag som stödjer omvårdnadsinterventioner, kliniskt beslutsfattande och ett personcentrerat bemötande av vuxna med ADHD (Ryttersund et al., 2020; Svensk sjuksköterskeförening, 2024).

Syfte

Syftet med studien var att sammanställa vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD.

Metod

Design

För att besvara studiens syfte valdes en integrativ litteraturstudie med en abduktiv ansats. Den integrativa metoden möjliggjorde inkludering av kvalitativa, kvantitativa och mixad metod-studier (Whittemore & Knafl, 2005). Analysen påbörjades induktivt genom en

förutsättningslös kodning av originalstudiernas fynd. I ett senare skede antogs en deduktiv riktning, där KASAM:s komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet användes som ett teoretisk ramverk för att forma studiens teman. Detta växelvisa arbetssätt kännetecknades av en pendling mellan empiri och teori där faserna tilläts flyta samman. Ansatsen bidrog till en öppenhet inför datamaterialet samt möjliggjorde att det undersökta fenomenet kunde belysas utifrån deltagarnas egna livsvärldar och hanterbarhet (Löfberg, 2022). Whittemore & Knafl (2005) integrativa metod tillämpades och följdes systematiskt genom litteraturstudiens fem steg (se figur 1).

Metoden möjliggjorde en syntes genom att integrera resultat från originalstudiernas olika metod och design. Valt problemområde kunde då belysas utifrån olika perspektiv vilket gav en bredare förståelse än en enskild studiedesign hade gjort (Polit & Beck, 2021; Whittemore & Knafl, 2005). För att säkerställa vetenskaplig tillförlitlighet genomfördes studien systematiskt, transparent och reproducerbart, där samtliga steg från litteratursökning till analys redovisades tydligt (Polit & Beck, 2021). Whittemore & Knafl (2005) framhåller att kvantitativ forskning ger kunskap om omfattning och samband, men har begränsad förmåga att fånga individers erfarenheter, vilka i stället kräver kvalitativa ansatser. De kvalitativa studierna bidrog således med beskrivningar av individers levda erfarenheter, medan de kvantitativa studierna tillförde objektiva mått såsom symtomnivåer, livskvalitet och funktionsförmåga.

Enligt Whittemore & Knafl (2005) innebär integrationen att resultaten inte analyseras separat, utan aktivt integreras med varandra. Tillsammans med kvalitativa data möjliggör detta en mer heltäckande förståelse av både upplevelsen och omfattningen av fenomenet. Genom att integrera olika metodologiska ansatser skapas förutsättningar för en bredare, mer sammanhållen och heltäckande analys, där både subjektiva och objektiva perspektiv inkluderas.



Figur 1. *Översikt av Whittemore & Knafl (2005) integrativa metod.*

Urval

Syftet var att sammanställa vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD. Urvalskriterier fastställdes före databassökningen och tillämpades konsekvent (se tabell 1). Avgränsning av tidsperioden till de senaste 10 åren säkerställde att inkluderat material speglade den senaste forskningen samt bidrog och möjliggjorde att samtida erfarenheter fångades. Endast studier skrivna på svenska eller engelska inkluderades. Artiklarna skulle vara originalstudier, peer- reviewed och etiskt godkända. Vuxna över 18 år med ADHD-diagnos inkluderades. Studier där en självrapporterad ADHD-diagnos kunde verifieras av forskarna efter screening med ett validerat skattningsinstrument för ADHD inkluderades, samt de studier där diagnoskriterierna för ADHD uppfylldes enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) (American Psychiatric Association (APA), 2026).

För att undvika att resultaten påverkades av andra sjukdomstillstånd exkluderades studier där deltagarna samtidigt hade viss samsjuklighet som kunde påverka kognitionen. Exklusion av studier med samsjuklighet ökade den interna validiteten men begränsade samtidigt överförbarheten till kliniska sammanhang där samsjuklighet är vanligt förekommande (Polit & Beck, 2021). Studier där forskarna exkluderat självrapporterad samsjuklighet inkluderades. Deltagare som blivit screenade för psykiatrisk samsjuklighet eller genomgått anamnesupptagning av forskarna inkluderades likaså, liksom deltagare som nekade till somatiska eller psykiatriska hälsotillstånd som påverkade den dagliga funktionen.

Tabell 1. *Inklusions- och exklusionskriterier*

Inklusionskriterier	Exklusionskriterier
Originalartiklar	Bipolär sjukdom
Vuxna över 18 år	Pågående substansbruk
Etiskt godkända	Autism (AST)
ADHD-diagnos	Psykossjukdom
Publikation i vetenskaplig tidskrift	Personlighetssyndrom

Kvantitativa studier	Ätstörning
Kvalitativa studier	
Mixad metod - studier	

Litteratursökning

Sökstrategin utvecklades i samarbete med bibliotekarie vid Blekinge Tekniska Högskola. Litteratursökningarna genomfördes i de vetenskapliga databaserna CINAHL och PubMed. Dessa valdes utifrån sina disciplinära fokus på omvårdnad respektive biomedicin.
Efter testsök valdes de primära sökorden ADHD, adults och life experiences. Dessa bedömdes vara relevanta för studiens syfte samt tillräckligt breda för att fånga vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD.

För att identifiera ämnesorden i de två databaserna användes databasernas lista för ämnesord, MeSH-termer i PubMed och Subject Headings i CINAHL. Ämnesorden kombinerades konsekvent med fritextord som var närliggande eller synonyma med respektive ämnesord. Vid databassökningen användes de booleska operatorerna AND och OR samt trunkering. AND användes för att kombinera sökbegrepp och avgränsa sökningen till studier som innehöll samtliga söktermer, medan OR användes för att inkludera synonymer och närliggande begrepp och därigenom bredda sökningen. Trunkering användes för att fånga olika böjningsformer och stavningsvarianter av samma sökord, vilket ökade sökningens känslighet (Polit & Beck, 2021). Sökstrategin bidrog till en systematisk och strukturerad litteratursökning med balans mellan sensitivitet och specificitet (Willman et al., 2016). Sökningar i två databaser möjliggjorde identifiering av både kvantitativa, kvalitativa och mixad metod-studier, vilket breddade det vetenskapliga underlaget (Polit & Beck, 2021). Sökschema redovisas i bilaga 1.

Totalt identifierades 1 241 sökträffar, varav 883 från PubMed och 358 från CINAHL. Samtliga 1 241 titlar screenades. Efter screening återstod 74 artiklar för granskning av abstract. Av dessa var 14 dubbletter. Återstående 60 abstract lästes. 44 artiklar exkluderades då de inte uppfyllde inklusionskriterierna för ålder och samsjuklighet. Andra artiklar svarade inte mot syftet, flertalet handlade om undervisning, medicinering, föräldraperspektivet och

övergången från barnpsykiatrin till vuxenpsykiatrin.

Efter granskning av abstract återstod 16 artiklar som gick vidare för läsning i fulltext. Efter fulltextläsning exkluderades sju artiklar som inte svarade mot studiens syfte, uppvisade exkluderande samsjuklighet eller inte redogjorde tillräckligt för deltagarnas ADHD-diagnos. Slutligen bedömdes nio artiklar uppfylla inklusionskriterierna för uppsatsen samt svarade mot syftet. Dessa översattes till svenska samt lästes upprepat på både svenska och engelska. Totalt inkluderades nio artiklar: sex kvalitativa, två mixad-metod och en kvantitativ. Fem artiklar identifierades i PubMed och fyra artiklar i CINAHL.

Denna strukturerade och systematiska strategi skapade förutsättningar för en bred och sensitiv sökning, samtidigt som specifika avgränsningar säkerställde relevans. Detta motverkade risken att enbart fånga ett enskilt perspektiv. Sökresultatet redovisas i ett flödesschema utifrån Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2025) (se bilaga 2). Sökningarna genomfördes mellan juni 2026 och juli 2026. Den sista sökningen gjordes den 25 juli 2026.

Datautvärdering

Vid kvalitetsgranskning betonar Whittemore & Knafl (2005) vikten av att använda systematiska och transparenta granskningsinstrument för att identifiera styrkor och svagheter samt för att säkerställa studiernas trovärdighet och minska risken bias.
Whittemore & Knafl (2005) anger inte någon specifik granskningsmall som måste användas. Studiernas metodologiska kvalitet ska bedömas på ett systematiskt sätt, men valet av granskningsmall lämnas till forskarna. En matris utformades för kvalitetsgranskning av artiklarna för att underlätta granskningen av de urval, metod, analys och resultat som dokumenterades (se bilaga 3).

De inkluderade studierna kvalitetsgranskades enligt Caldwell et al. (2011) granskningsmall (se bilaga 4). Valet motiverades av att uppsatsen genomfördes enligt Whittemore & Knafl (2005) metod för integrativa studier som inkluderade kvalitativa, kvantitativa och mixad metod-studier. För mixad metod-studierna granskades de kvalitativa och kvantitativa delarna separat, innan en samlad bedömning gjordes av hur väl metoderna integrerades för att besvara studiens syfte. Granskningsmallen innehåller ingen separat bedömning av bias, risken för bias

bedömdes utifrån studiernas urval, datainsamling, analys och generella metodologiska kvalitet (Caldwell et al., 2011).

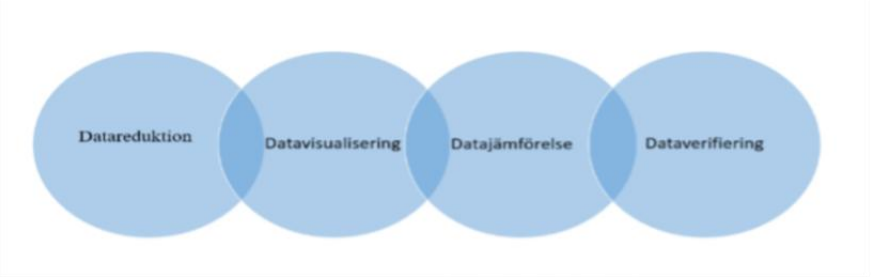
Enligt Caldwell et al. (2011) granskas kvantitativa studier med fokus på forskningsdesign, urval, validitet, reliabilitet och statistisk analys. Kvalitativa studier granskas utifrån forskningsansats, urval, datainsamling, analys samt trovärdighet och överförbarhet. Validitet och reliabilitet används främst i kvantitativ forskning och beskriver om ett instrument mäter rätt sak samt om mätningen görs på ett tillförlitligt sätt. Trovärdighet och överförbarhet används främst i kvalitativ forskning och beskriver hur väl resultaten speglar deltagarnas erfarenheter samt i vilken utsträckning resultaten kan vara relevanta i andra sammanhang.

Artiklarna bedömdes utifrån hög, medelhög eller låg kvalitet. Samtliga nio artiklar bedömdes ha tillräcklig metodologisk kvalitet för att inkluderas i litteraturstudie. Sju studier bedömdes ha hög kvalitet och två studier medelhög kvalitet. Ingen studie exkluderades på grund av låg kvalitet. De främsta metodologiska styrkorna var tydligt formulerade syften, välmotiverade metodval, verifierade ADHD-diagnoser, etiskt godkännande samt transparenta och systematiskt beskrivna analysprocesser. Flera studier redovisade dessutom strategier för att stärka trovärdigheten, såsom datamättnad, triangulering, respondentvalidering och användning av flera datakällor. Detta minskade risken för bias och ökade resultatens tillförlitlighet.

De vanligaste metodologiska begränsningarna utgjordes av små och självselekterade urval, överrepresentation av kvinnor och begränsad verifiering av samsjuklighet. I flera artiklar bedömdes även överförbarheten vara begränsad på grund av homogena urval eller specifika deltagargrupper, exempelvis universitetsstudenter eller yrkesverksamma kvinnor med ADHD. Trots dessa begränsningar bedömdes studiernas samlade kvalitet vara tillräckligt god för att kunna inkluderas i den integrerade analysen. De inkluderade studierna sammanställdes i en artikelöversikt och numrerades (se bilaga 5). (Caldwell et al., 2011; Whittemore & Knafl, 2005).

Dataanalys

För att hantera komplexiteten krävdes en strukturerad analysprocess. Dataanalysen följde, systematiskt och strukturerat, Whittemore & Knafl (2005) metodartikel och dess fyra steg (se figur 2). Denna kännetecknas av en iterativ process där forskaren rör sig fram och tillbaka mellan processens olika steg.



Figur 2. *Analysprocessen enligt Whittemore & Knafl (2005).*

Datareduktion och datavisualisering

Datareduktion syftar till att göra ett omfattande datamaterial hanterbart genom att extrahera specifika meningsbärande enheter från artiklarna (Whittemore & Knafl, 2005). Processen inleddes med att relevanta fynd som svarade på syftet identifierades, extraherades och dokumenterades i en strukturerad dataanalysmatris (se tabell 2). Varje extraherad meningsbärande enhet färgkodades och numrerades och lades in i dataanalysmatrisen för att bibehålla en tydlig spårbarhet till den ursprungliga originalkällan. Genom denna iterativa och systematiska process reducerades datamaterialet successivt. Meningsbärande enheter formulerades i relation till syftet. För att organisera och strukturera materialet sammanställdes koderna i dataanalysmatrisen, vilket motsvarar det steg som Whittemore & Knafl (2005) benämner datavisualisering. Denna visualisering syftade till att ge en systematisk överblick över det samlade extraherande data, vilket var en förutsättning för att möjliggöra och underlätta efterföljande jämförelser och mönsteridentifiering mellan de inkluderade studierna. Genom att återkommande återvända till originalartiklarna under reduktions- och visualiseringsfasen säkerställdes att de meningsbärande enheterna inte lyftes ur sitt sammanhang, vilket motverkade risken för subjektiva tolkningar, betydelseförskjutning och stärkte studiens tillförlitlighet (Willman et al., 2016).

Tabell 2. *Exempel på dataanalysmatrisen utifrån extraherande data från artiklarna.*

Steg	Innehåll
Meningsbärande enhet	3.Erfarenheter av negativ kritik från omgivningen. 6.Tillskrevs negativa egenskaper som var ADHD-relaterade. 7.Konsekvenser ledde till låg självkänsla, skam och misslyckande. 9.Internalisering.

Kod	Självbild
Undertema	Att bära med sig konsekvenser av kritik och otillräcklighet
Tema	Att förstå sig själv och sin historia

Datajämförelse

Datajämförelsen utgjorde ett centralt steg i analysprocessen och syftade till att systematiskt identifiera mönster, likheter, skillnader och relationer mellan studiernas (Polit & Beck, 2021; Whittemore & Knafl, 2005). För att underlätta jämförelser mellan studierna sammanställdes dessa i en jämförelsematris (se bilaga 6). Variabler som land, urval, kontext, metod, analys och centrala fynd användes som variabler för att förklara, tolka och förstå variationer i studiernas fynd och analyserades inte som primära resultat. Det inkluderade datamaterialet uppvisade en bredd gällande både geografi och livsfaser. Studier från USA, Storbritannien, Norge, Nederländerna och Israel belyste erfarenheter från utbildnings-, arbetslivs-, vård- och vardagskontexter. Urvalen omfattade både kvinnor och män, enstaka studier inkluderade endast kvinnor. Dessa variationer beaktades i jämförelseprocessen. Exempelvis jämfördes erfarenheter hos yngre universitetsstudenter (Maeir et al., 2026) mot erfarenheter hos äldre vuxna (Michielsen et al., 2018). Detta möjliggjorde en analys av hur erfarenheterna av ADHD upplevdes i olika skeden av livet.

Jämförelser gjordes även mellan studier med skilda fokus på kontexter. Specifika erfarenheter av läkemedelsbehandling och psykiatriska vårdkontakter (Barnes et al., 2026) jämfördes med erfarenheter kopplade till arbete, daglig aktivitet och praktiska anpassningsstrategier i vardagen (Paley et al., 2025; Schreuer & Dorot, 2017). Vidare integrerades studier som specifikt bidrog med kunskap om positiva erfarenheter och upplevda personliga styrkor (Nordby et al., 2023).

Integrationen av olika forskningsmetoder fördjupade jämförelsen. De kvalitativa studierna, till exempel (Barnes et al., 2026; Michielsen et al., 2018; Schreuer & Dorot, 2017) bidrog med rika, subjektiva beskrivningar av deltagarnas erfarenheter rörande självbild, relationer och vardagsliv. Den kvantitativa studien (Maeir et al., 2026) synliggjorde funktionella och neurokognitiva svårigheter genom statistiska mått, medan mixad metod-studierna (Babinski & Libsack, 2025; Ben-Dor Cohen et al., 2024) länkade samman dessa perspektiv

genom att kombinera skattningsskalor med kvalitativa intervjudata. Denna konstanta och iterativa jämförelseprocess (Whittemore & Knafl, 2005) visade att det trots metodologiska och kontextuella skillnader fanns en hög grad av samstämmighet kring erfarenheter av att leva med ADHD som vuxen.

Dataverifiering och slutsats

Datasyntes och verifiering utgjorde analysens slutskede och syftade till att sammanföra fynden till en ny, sammanhängande helhetsförståelse av vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD (Whittemore & Knafl, 2005). För att säkerställa att tolkningarna och de framväxande temana var helt förankrade i primärdatan, tillämpades ett kontinuerligt, systematiskt arbetssätt där de preliminära resultaten regelbundet prövades mot originalartiklarna. Processen innebar att meningsbärande enheter och citat återkommande lästes i sina ursprungliga sammanhang för att kontrollera att inga förskjutningar av betydelsen hade skett under abstraktionen. Genom att på detta sätt systematiskt verifiera de syntetiserade temana mot originaldata minskade risken för subjektiva feltolkningar, vilket stärkte studiens slutgiltiga tillförlitlighet och vetenskapliga stringens (Whittemore & Knafl, 2005).

Etiska överväganden

Denna uppsats genomfördes som en integrativ litteraturstudie baserad på tidigare publicerad originalforskning. Någon egen etikprövning krävdes inte, eftersom studien inte omfattade biologiskt material från människor eller behandling av känsliga personuppgifter på det sätt som avses i etikprövningslagen (SFS 2003:460). Trots att studien inte omfattades av formella krav på etikprövning, genomfördes arbetet i enlighet med principerna om god forskningssed, vilka betonar ärlighet, öppenhet, noggrannhet och ansvar genom hela forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2024).

De centrala etiska principerna om människovärde, integritet och objektivitet har legat till grund för arbetet och följdes konsekvent under hela processen. För att stärka studiens trovärdighet eftersträvades en objektiv och transparent redovisning av det sammanställda resultatet. Författarnas förförståelse och kliniska erfarenheter av psykiatrisk vård och ADHD identifierades som faktorer som initialt skulle kunna påverka tolkningen av datamaterialet. För att minimera risken för tolkningsbias granskades, analyserades och diskuterades materialet därför fortlöpande gemensamt under hela analysprocessen (Vetenskapsrådet, 2024).

De inkluderade artiklarnas etiska genomförande bedömdes noggrant. Särskild uppmärksamhet riktades mot huruvida studierna hade erhållit godkännande från relevant etikprövningsnämnd samt om forskarna redovisade grundläggande etiska överväganden såsom informerat samtycke, frivilligt deltagande, konfidentialitet och deltagarnas rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Denna granskning genomfördes för att säkerställa att litteraturstudiens resultat uteslutande baserades på forskning som genomförts på ett etiskt riktigt sätt (Vetenskapsrådet, 2024).

Resultat

Totalt inkluderades nio artiklar i studien, sex kvalitativa, två med mixad metod och en kvantitativ. Av dessa hämtades fem från databasen PubMed och fyra från CINAHL. För att besvara studiens syfte om vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD antogs en abduktiv ansats. Resultatet analyserades först induktivt för att sedan struktureras deduktivt utifrån KASAM:s tre komponenter *begriplighet*, *hanterbarhet* och *meningsfullhet*, vilka presenteras med vardera två underteman (se tabell 3).

Tabell 3. *Tema och undertema.*

Tema	**Att förstå sig själv och sin historia**	**Att upprätthålla funktion genom reglering och kompensation**	**Att bevara sig själv i förändring**
Undertema	Erfarenhet av en sårad självbild	Reglera inre belastning	Identifiera egna resurser i det egna sättet att fungera
Undertema	Förstå sina erfarenheter i ljuset av ADHD	Skapa yttre strukturer	Forma ett hållbart liv utifrån egna villkor

Resultatet beskriver vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD genom tre teman. Det första temat, *Att förstå sig själv och sin historia,* handlar om begriplighet och belyser hur den inre självbilden med erfarenheter av återkommande kritik, känslor av otillräcklighet och bristande förståelse från omgivningen påverkade deltagarnas självbild och relationer från låg ålder och före diagnos. Tema två, *Att upprätthålla funktion genom reglering och kompensation*, belyser främst hur ADHD-diagnosen och hur deltagarna hanterade och kompenserade med yttre stöd och hjälpmedel samt en inre reglering för att fungera. Det tredje temat, *Att bevara sig själv i förändring* fokuserar på vem de är, hur de vill leva samt hur de kan navigera och forma sitt liv på sina egna villkor. Detta innebär att få en stabilare känsla av sin identitet och en ökad meningsfullhet.

Tema 1. Att förstå sig själv och sin historia

Resultatet visade att vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD präglades av en successiv utveckling av förståelsen för den egna personen och dess livshistoria (Babinski & Libsack, 2025; Barnes et al., 2026; Beaton et al., 2022; Paley et al., 2025). Före diagnos saknade deltagarna ofta en förklaringsmodell för sina återkommande misslyckanden och svårigheter, vilket gjorde det svårt att förstå sambandet mellan egna erfarenheter och sättet att fungera (Michielsen et al., 2018; Paley et al., 2025). Diagnosen framträdde som en central vändpunkt som möjliggjorde en omtolkning av tidigare erfarenheter vilket bidrog till en mer sammanhängande förståelse av den egna livsberättelsen (Babinski & Libsack, 2025; Barnes et al., 2026; Nordby et al., 2023; Paley et al., 2025).

1.1 Erfarenheter av en sårad självbild

Vuxna med ADHD beskrev hur erfarenheterna av att leva med ADHD sedan låg ålder präglades av återkommande kritik, negativa omdömen och svårigheter att leva upp till omgivningens förväntningar (Michielsen et al., 2018; Paley et al., 2025; Schreuer & Dorot, 2017). Kritiken var ofta kopplad till exekutiva svårigheter såsom uppmärksamhet, organisering, tidsuppfattning, impulsivitet och socialt samspel (Michielsen et al., 2018; Paley et al., 2025; Schreuer & Dorot, 2017). Eftersom deltagarna under lång tid saknade en förklaring till sina svårigheter, tolkades motgångar och misslyckanden ofta som uttryck för personliga brister snarare än som konsekvenser av ADHD-egenskaper (Michielsen et al., 2018; Paley et al., 2025).

Omgivningens negativa tillskrivningar internaliserades gradvis, vilket ledde till att deltagarna beskrev sig själva som slarviga, kaotiska, omogna eller oförmögna att göra rätt (Beaton et al.,

2022; Michielsen et al., 2018; Paley et al., 2025). När goda ambitioner och intentioner upprepade gånger inte kunde omsättas i praktisk handling förstärktes upplevelsen av att något var fel hos den egna personen (Paley et al., 2025; Schreuer & Dorot, 2017). Detta återkommande glapp mellan vilja och förmåga bidrog till stress, självtvivel och minskad tilltro till den egna kapaciteten (Nordby et al., 2023; Paley et al., 2025).

Att inte förstå eller klara av sådant som upplevdes som självklart för andra bidrog till en varaktig känsla av otillräcklighet och låg självkänsla (Beaton et al., 2022; Michielsen et al., 2018). Denna sårbarhet kvarstod även i vuxenlivet genom en ökad känslighet för kritik, där negativa kommentarer ofta uppfattades som bekräftelser på tidigare erfarenheter av misslyckande (Beaton et al., 2022; Schreuer & Dorot, 2017).

1.2 Förstå sina erfarenheter i ljuset av ADHD

Att få en ADHD-diagnos i vuxen ålder innebar för många deltagare en genomgripande förändring i förståelsen av den egna personen och livshistorien (Babinski & Libsack, 2025; Barnes et al., 2026; Nordby et al., 2023; Paley et al., 2025). Diagnosen gav en förklaring som gjorde det möjligt att förstå tidigare svårigheter och konsekvenser av ADHD-relaterade funktionsnedsättningar i stället för personliga tillkortakommanden (Babinski & Libsack, 2025; Barnes et al., 2026; Paley et al., 2025). Genom denna successiva omtolkning blev tidigare erfarenheter av misslyckanden, kritik och utanförskap begripliga, som delar av ett sammanhängande livsmönster (Barnes et al., 2026; Nordby et al., 2023; Paley et al., 2025).

Diagnosen gjorde det möjligt att skilja den egna personen från svårigheterna och bidrog därmed till en mer sammanhållen och mindre dömande självbild (Barnes et al., 2026; Paley et al., 2025).

Samtidigt innebar den nya förståelsen ofta en känslomässig konfrontation med det förflutna (Babinski & Libsack, 2025; Barnes et al., 2026). Deltagarna beskrev sorg, ilska och reflektioner över förlorade möjligheter när de blev medvetna om hur länge deras svårigheter förblivit oförstådda (Babinski & Libsack, 2025; Nordby et al., 2023). Trots dessa känslor framträdde diagnosen som en avgörande vändpunkt, eftersom den gav deltagarna möjlighet att förstå tidigare erfarenheter på ett nytt sätt och skapa en mer begriplig bild av den egna livshistorien (Barnes et al., 2026; Nordby et al., 2023; Paley et al., 2025).

Tema 2. Att upprätthålla funktion genom reglering och kompensation

Temat beskriver hur vuxna med ADHD strävade efter att skapa hanterbarhet i en vardag som präglades av krav på självkontroll, planering och anpassning. Erfarenheterna visade att hanterbarheten formades genom ett kontinuerligt samspel mellan individens egna regleringsstrategier och tillgången till yttre stödstrukturer. Samtidigt framträdde hanterbarhet som en skör process, där ökade krav eller förändrade livsvillkor kunde utmana tidigare fungerande strategier.

2.1. Att reglera inre belastning

Deltagarna beskrev att vardagen med ADHD var ett kontinuerligt arbete med att reglera känslor, impulser och beteenden i relation till omgivningens krav (Ben-Dor Cohen et al., 2024; Schreuer & Dorot, 2017). Självreglering framträdde som en central del av vardagsfungerandet, där individerna ständigt behövde övervaka sina reaktioner och anpassa sitt beteende för att kunna fungera i arbete, relationer och sociala sammanhang (Ben-Dor Cohen et al., 2024; Schreuer & Dorot, 2017).

Svårigheter med känslomässig intensitet, frustration och impulsivitet påverkade deltagarnas möjligheter att hantera vardagliga situationer på det sätt de själva önskade (Ben-Dor Cohen et al., 2024; Michielsen et al., 2018; Schreuer & Dorot, 2017). När stressnivån ökade eller situationer ställde höga krav på flexibilitet och självkontroll blev självregleringen mer sårbar, vilket kunde leda till reaktioner och agerande som deltagarna senare upplevde som ogenomtänkta eller svåra att stå för (Ben-Dor Cohen et al., 2024; Schreuer & Dorot, 2017). Dessa situationer kunde resultera i missförstånd, konflikter och efterföljande självkritik (Beaton et al., 2022; Schreuer & Dorot, 2017).

För att hantera denna inre belastning utvecklade deltagarna olika självreglerande strategier (Ben-Dor Cohen et al., 2024). Strategierna omfattade bland annat att stanna upp före handling, reflektera över sina reaktioner, identifiera utlösande faktorer och skapa ett medvetet avstånd mellan impuls och handling (Ben-Dor Cohen et al., 2024; Schreuer & Dorot, 2017). Ökad medvetenhet om kroppsliga signaler, känslotillstånd och risksituationer beskrevs också vilket stärkte möjligheten att agera mer genomtänkt i krävande sammanhang (Ben-Dor Cohen et al., 2024). Hanterbarheten blev därmed delvis beroende av individens förmåga att upprätthålla kompensatoriska strategier, vilket samtidigt riskerade att bidra till stress och utmattning över tid (Michielsen et al., 2018; Paley et al., 2025).

Självreglering visade sig vara en skör resurs som krävde betydande mental energi för att upprätthållas över tid (Ben-Dor Cohen et al., 2024; Michielsen et al., 2018). Kunskap om hjälpsamma strategier var inte alltid tillräcklig för att kunna omsättas i praktisk handling, eftersom strategierna ofta behövde aktiveras just i situationer där den kognitiva belastningen redan var hög (Ben-Dor Cohen et al., 2024; Maeir et al., 2026). Hanterbarheten blev därmed beroende av en ständig balans mellan individens regleringsförmåga och de krav som situationen ställde (Ben-Dor Cohen et al., 2024; Schreuer & Dorot, 2017).

2.2 Skapa yttre strukturer

Självreglering var sällan tillräcklig för att skapa en fungerande vardag. Att hantera vardagen byggde även på användning av yttre strukturer. (Michielsen et al., 2018; Paley et al., 2025; Schreuer & Dorot, 2017). För att avlasta arbetsminnet, skapa överblick och minska risken för glömska använde deltagarna praktiska verktyg såsom listor, kalendrar, scheman och digitala påminnelser (Michielsen et al., 2018; Schreuer & Dorot, 2017). Dessa strukturer fungerade som stöd för att överbrygga skillnaden mellan vardagens krav och individens exekutiva förutsättningar (Maeir et al., 2026; Schreuer & Dorot, 2017).

Arbets-, studie-, och vardagsmiljöers utformning var av stor betydelse för hanterbarheten (Maeir et al., 2026; Paley et al., 2025; Schreuer & Dorot, 2017). Möjligheten att arbeta i lugnare miljöer, begränsa störande intryck, ta planerade pauser och kunna påverka arbetstempot bidrog till att minska belastningen och skapade bättre förutsättningar för funktionen (Paley et al., 2025; Schreuer & Dorot, 2017). När miljön präglades av hög sensorisk belastning, många samtidiga krav eller otydliga förväntningar blev svårigheterna mer framträdande och vardagen svårare att hantera (Maeir et al., 2026; Schreuer & Dorot, 2017). Det framkom att vardagen ofta präglades av ett kontinuerligt arbete att dölja eller kompensera för svårigheter (Michielsen et al., 2018; Paley et al., 2025; Schreuer & Dorot, 2017).

Maskering användes för att framstå som fungerande och kompetent samt för att minska risken för kritik, missförstånd och social exkludering (Beaton et al., 2022; Paley et al., 2025). Samtidigt beskrevs dessa anpassningar som mycket energikrävande och beroende av en investering av tid, uppmärksamhet och självkontroll (Paley et al., 2025; Schreuer & Dorot, 2017). Genom att lägga ner mer tid och energi än andra, kontrollera sitt beteende eller utveckla individuella sätt försökte de upprätthålla en bild av kompetens och funktion (Paley et al., 2025; Schreuer & Dorot, 2017). Dessa kompensatoriska anpassningar möjliggjorde

deltagande i arbete, studier och sociala sammanhang, men var samtidigt energikrävande och svåra att upprätthålla över längre tid (Paley et al., 2025; Schreuer & Dorot, 2017).

Medicinsk behandling och professionella vårdkontakter var yttre resurser som stabiliserade ADHD-symtomen, uppmärksamhet och koncentration (Barnes et al., 2026). Medicineringen visade en dubbelsidig erfarenhet. Samtidigt som den avlastade vardagen, ställde den nya krav på individens hanterbarhet i form av biverkningar och behov av återkommande täta uppföljningar och kontakter med sjukvården (Barnes et al., 2026).

I samband med större livsförändringar där tidigare rutiner, roller och stödstrukturer fungerat sågs ett försämrat fungerande (Babinski & Libsack, 2025; Maeir et al., 2026; Michielsen et al., 2018). Övergångar såsom högre studier, förändrade arbetsförhållanden, familjebildning och pensionering ökade kraven på planering, organisering och självständighet, vilket gjorde tidigare strategier otillräckliga (Babinski & Libsack, 2025; Maeir et al., 2026; Michielsen et al., 2018).

Tema 3. Att bevara sig själv i förändring

Meningsfullhet i vuxenlivet med ADHD utvecklades när individen kunde integrera sina svårigheter och resurser i en mer accepterande självförståelse (Babinski & Libsack, 2025; Nordby et al., 2023; Paley et al., 2025). Detta framträdde genom att identifiera personliga styrkor och skapa ett liv som utgick från egna behov, värderingar och förutsättningar (Nordby et al., 2023; Paley et al., 2025; Schreuer & Dorot, 2017). Temat beskriver hur vuxna med ADHD strävade efter att leva i samklang med sig själva snarare än att anpassa sig till omgivningens förväntningar (Babinski & Libsack, 2025; Nordby et al., 2023; Paley et al., 2025).

3.1. Att identifiera resurser i det egna sättet att fungera

När deltagarna utvecklade en ökad förståelse för sin ADHD började de också omvärdera sitt sätt att fungera och upptäckte resurser som tidigare varit osynliga eller nedvärderade (Nordby et al., 2023; Paley et al., 2025). ADHD beskrevs inte enbart som en källa till svårigheter utan även som en källa till egenskaper som kreativitet, nyfikenhet, energi, spontanitet och förmåga att tänka på nya sätt (Nordby et al., 2023; Schreuer & Dorot, 2017). Deltagarna lyfte också fram hyperfokus som en egenskap som gjorde det möjligt att fördjupa sig i uppgifter och intressen som upplevdes meningsfulla (Nordby et al., 2023; Paley et al., 2025).

Samma egenskaper kunde vara både tillgångar och belastningar beroende på sammanhanget (Nordby et al., 2023). Hög energi kunde bidra till drivkraft och initiativförmåga men också leda till överbelastning och utmattning när återhämtning saknades (Nordby et al., 2023; Paley et al., 2025). Spontanitet kunde skapa möjligheter till nya erfarenheter och relationer men samtidigt resultera i impulshandlingar som senare upplevdes problematiska (Nordby et al., 2023).

3.2. Att forma ett hållbart liv utifrån egna villkor

Motgångar och långvariga svårigheter sågs ha bidragit till personlig utveckling, ökad självkännedom och motståndskraft (Nordby et al., 2023). Att omvärdera tidigare erfarenheter ledde i stor utsträckning till att de såg sig själva som kompetenta individer med unika resurser snarare än som personer som definierades av sina svårigheter (Nordby et al., 2023; Paley et al., 2025). Denna förändrade självbild bidrog till ökad självacceptans och skapade förutsättningar för att uppleva livet som mer meningsfullt (Babinski & Libsack, 2025; Nordby et al., 2023).

Successivt lärde de sig att göra mer medvetna val kring arbete, studier, relationer och fritidsaktiviteter (Paley et al., 2025; Schreuer & Dorot, 2017). Att välja aktiviteter som väckte intresse och engagemang upplevdes som särskilt betydelsefullt eftersom motivationen stärkte förmågan att bibehålla fokus och uthållighet över tid (Paley et al., 2025). När vardagen kunde organiseras utifrån det som upplevdes viktigt och värdefullt för individen själv, snarare än utifrån normativa ideal om hur man borde fungera, skapades meningsfullhet (Nordby et al., 2023; Paley et al., 2025).

Acceptans av den egna funktionsnedsättningen beskrevs minska behovet av att ständigt jämföra sig med andra eller försöka dölja sina svårigheter (Babinski & Libsack, 2025; Schreuer & Dorot, 2017). När kravet på att framstå som ”normal” minskade, frigjordes energi som kunde investeras i relationer, aktiviteter och mål som upplevdes genuint betydelsefulla (Paley et al., 2025; Schreuer & Dorot, 2017). Detta bidrog till en ökad känsla av autonomi och personlig egen kontroll, där deltagarna i högre grad upplevde sig kunna påverka riktningen i sina liv (Ben-Dor Cohen et al., 2024; Paley et al., 2025).

Meningsfullhet handlade ytterst om möjligheten att leva i samklang med sina egna förutsättningar snarare än att ständigt försöka kompensera för dem (Nordby et al., 2023; Paley et al., 2025). När de kunde integrera sina svårigheter, resurser och erfarenheter i

en mer sammanhållen självförståelse skapades förutsättningar för ett liv präglat av större acceptans, riktning och upplevd mening (Babinski & Libsack, 2025; Nordby et al., 2023; Paley et al., 2025).

Diskussion

Metoddiskussion

Studiens abduktiva ansats medförde både styrkor och utmaningar. Att initiera analysen induktivt och förutsättningslöst minskade risken för att förförståelsen skulle styra den initiala kodningen. Det säkrade att vuxnas erfarenheter framträdde fritt ur rådatan. Att i slutskedet övergå till en deduktiv sortering utifrån KASAM höjde studiens abstraktionsnivå och gav resultatet en tydlig omvårdnadsteoretisk struktur. Samtidigt innebar skiftet en risk för konfirmationsbias, då fasta begrepp riskerar att tvinga eller snedvrida datamaterialet. För att motverka detta och stärka studiens pålitlighet (dependability) skedde en ständig pendling tillbaka till originaltexterna (Löfberg, 2022) parallellt med fortlöpande diskussioner mellan författarna.

Enligt Whittemore & Knafls (2005) tillåter en integrativ litteraturstudie en kombination av skilda forskningsdesigner, vilket möjliggjorde en flersidig belysning av vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD. Genom att sammanföra kvalitativa djupintervjuer med kvantitativa data bidrog detta till att ämnet kunde belysas från flera olika håll, vilket stärkte studiens giltighet. Det innebar dock källkritiska utmaningar rörande datamaterialets likformighet, urvalsbias och mätmetoder, vilket krävde en kritisk reflektion. Kombinationen av olika metoder gjorde datamaterialet svårt att jämföra rakt av. De inkluderade studierna använde olika kvalitativa datainsamlingsmetoder, vilket kan ha påverkat resultatens djup och karaktär. Babinski & Libsack (2025) fokusgrupper kan ha stimulerat reflektion och möjliggjort att erfarenheter utvecklades och förstärktes genom gruppdiskussioner. Samtidigt finns en risk att vissa erfarenheter inte uttrycktes av hänsyn till gruppen eller social önskvärdhet.

Michielsen et al. (2018) använde individuella djupintervjuer, vilket möjliggjorde utforskning av personliga och känsliga erfarenheter samt gav utrymme för nyanserade berättelser om att leva med ADHD över livsloppet. Beaton et al. (2022) baserade däremot sitt material på skriftliga fritextsvar i en webbenkät, vilket möjliggjorde insamling av data från ett större och geografiskt mer varierat urval, men begränsade forskarnas möjlighet att ställa följdfrågor och

fördjupa deltagarnas beskrivningar. Flera studier tillämpade strikta inklusions- och exklusionskriterier för att säkerställa att deltagarna hade en verifierad ADHD-diagnos, vilket kan ha stärkt studiernas interna trovärdighet (Michielsen et al., 2018; Nordby et al., 2023; Paley et al., 2025; Schreuer & Dorot, 2017). Samtidigt exkluderades personer med psykiatrisk eller neurologisk samsjuklighet i flera av studierna. Detta kan ha bidragit till mer homogena urval och därmed begränsat variationen av erfarenheter som inkluderades i resultaten. (Nordby et al., 2023; Paley et al., 2025; Schreuer & Dorot, 2017) Eftersom samsjuklighet är vanligt förekommande hos vuxna med ADHD finns en risk att resultaten i mindre utsträckning speglade den heterogena patientgrupp som ses kliniskt (Michielsen et al., 2018; Nordby et al., 2023; Paley et al., 2025; Schreuer & Dorot, 2017). Urvalet kan ha medfört att resultatet inte fullt ut speglade den kliniska ADHD-populationen då samsjuklighet är vanligt förekommande. Därmed kan studiens överförbarhet till patientgruppen begränsats, då urvalet riskerar att ha blivit alltför homogent.

En metodologisk begränsning var den geografiska fördelningen av artiklarna. Fyra av de nio studierna genomfördes i Israel. Att nästan hälften av studierna kom från en enskild nation och annan kulturell kontext kan ha påverkat resultatets överförbarhet (transferability) till svenska förhållanden (Polit & Beck, 2021). Sjukvårdsystem, kultur och samhällssystem fungerar och ser olika ut och har sina egna specifika system. Denna snedfördelning balanserades dock av att resterande studier genomförts i USA, Storbritannien, Norge och Nederländerna. I en av studierna fanns ett internationellt urval. Trots strukturella skillnader i ländernas vårdsystem framkom en samstämmighet i resultaten gällande erfarenheter av exekutiv dysfunktion, social utsatthet och behovet av förståelse. Att studierna pekade åt samma håll minskade den negativa geografiska dominansen och stärkte resultatets övergripande pålitlighet (dependability) (Whittemore & Knafl, 2005).

Utöver den geografiska spridningen visade artiklarna genusbias. Majoriteten av deltagarna i de sammanställda studierna var kvinnor (Polit & Beck, 2021). Några studier inkluderade endast kvinnliga deltagare. Denna snedfördelning återspeglade den kliniska verkligheten där vuxna kvinnor i högre grad söker vård för ADHD till följd av att deras inåtvända symtom ofta förbisetts under barndomen Babinski & Libsack, (2025) vilket Wang et al. (2025) också belyser. Metodologiskt begränsade resultatets externa validitet då syntesen bland annat vilade på kvinnors levda erfarenheter av social maskering och anpassningsstrategier i arbets- och familjeliv. Överförbarheten till vuxna män med ADHD begränsades därmed, liksom mäns

erfarenheter och eventuella behov av stöd som kan ha underrepresenterats i den slutgiltiga syntesen (Polit & Beck, 2021; Whittemore & Knafl, 2005). Språkbegränsningarna till svenska och engelska kan ha medfört språk- och publikationsbias.

Datan spände över ett brett åldersspann, från universitetsstudenter i 20-årsåldern via yrkesverksamma i medelåldern till äldre vuxna över 65 år. Detta innebar en analytisk utmaning då sociala roller och krav förändras över tid. Yngre deltagare i Maeir et al. (2026) beskrev utmaningar kopplade till akademiska miljöer medan medelålders deltagare lyfte komplexa vuxenroller som föräldraskap. I skarp kontrast stod de äldre vuxna i studien av Michielsen et al. (2018) där forskarna diagnostiserat deltagarna med ADHD, men inte informerat deltagarna, vilket innebar att de under intervjutillfällena var helt omedvetna om sin diagnos. Detta begränsade jämförelsen då deltagarna inte kunnat reflektera över diagnosen eller koppla sina strategier till en formell medicinsk självförståelse, till skillnad från deltagarna i exempelvis Barnes et al. (2026). Styrkan var dock att studien erbjöd en autentisk blick på det rena åldrandet med ADHD-symtom, helt fri från vårdens eller diagnosens inverkan på deras berättelser.

Trovärdigheten påverkades även av hur ADHD-diagnoserna fastställts i primärstudierna. Självrapporterad ADHD från anonyma deltagare i Beaton et al. (2022) ökar risken för informationsbias (Whittemore & Knafl, 2005). Detta utgjorde en sårbarhet som dock uppvägdes av att övriga studier med hög noggrannhet och klinisk säkerhet i diagnostiken också inkluderats. Majoriteten av de inkluderade studiernas deltagare screenades med Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS), vilket är ett erkänt, validerat instrument som bygger direkt på DSM-kriterierna (Brevik et al., 2020). Även om Brevik et al. (2020) framhåller att ASRS har en generellt hög diagnostisk noggrannhet, medför instrumentet en klinisk osäkerhet för vuxna då det påverkas av individens aktuella dagsform, medicinering samt risken för minnesfel vid retrospektiv skattning. Eftersom DSM-kriterierna historiskt är utvecklade utifrån barn, riskerar detta förfarande att exkludera vuxna som utvecklat framgångsrika kompensatoriska strategier för att maskera sina symtom i vardagen (Babinski et al., 2025; Cortese et al., 2025; Kooij et al., 2019).

Liksom i Beaton et al. (2022) och Ben-Dor Cohen et al. (2024) exkluderades studier med svår psykiatrisk eller somatisk samsjuklighet i denna uppsats vilket höjde den interna validiteten genom att “renodla” fenomenet (Whittemore & Knafl, 2005). Detta kan ha genererat en klyfta till den kliniska verkligheten där samsjuklighet snarare är regel än undantag (Cortese et al.,

2025; Faraone et al., 2021).

Analysens trovärdighet (credibility) stärks av att datautvärderingen och analysfasen följde en transparent och tydlig struktur baserad på metoden av Whittemore & Knafl (2005). Processen präglades av en kontinuerlig, iterativ process mellan extraherade data och originalartiklarna. Detta säkerställde att inga betydelseförskjutningar skedde. Analysprocessen genomfördes genom fortlöpande dialog mellan författarna vilket minskade risken för individuell tolkningsbias och höjde därmed studiens tillförlitlighet (Polit & Beck, 2021; Willman et al., 2016).

För att besvara syftet hade en kvalitativ metasyntes varit ett starkt alternativ till den valda integrativa metoden. Då erfarenheter är ett kvalitativt fenomen, hade en renodlad kvalitativ metod möjliggjort en djupare tolkning av vuxnas levda verklighet. Det hade även eliminerat de källkritiska utmaningar som uppstår när skilda forskningsdesigner sammanförs i en integrativ studie.

Resultatdiskussion

Syftet med denna integrativa litteraturstudie var att sammanställa vuxnas erfarenheter av att leva med ADHD. Kvalitativ och kvantitativ forskning sammanställdes till två centrala fokusområden, självbildens genes samt kritiska livshändelsers betydelse (Beaton et al., 2022; Paley et al., 2025). Dessa områden valdes ut eftersom de belyser hur individens neurobiologiska sårbarhet flätades samman med omgivningens bemötande och strukturella krav (Bjerrum et al., 2017; Hansson Halleröd et al., 2015). För att analysera innebörden av dessa erfarenheter speglades resultatet genom ramverket KASAM (Antonovsky, 2005). Det sammanställda resultatet visade att vuxnas erfarenheter av sin självbild inte var ett statiskt tillstånd. Det handlade i stället om en sårbar kognitiv process som sträckte sig från barndomen och följde med upp i vuxen ålder. Tiden före diagnos kännetecknades av en försvagad begriplighet i vardagen (Bjerrum et al., 2017; Nyström et al., 2020; Schrevel et al., 2015). Individerna saknade en förklaring till sina svårigheter, vilket ledde till att de tolkade sina återkommande exekutiva misslyckanden som personliga brister snarare än som symtom (Nyström et al., 2020; Rosenthal et al., 2025). Omgivningens dömande tillskrivningar och missförstånd internaliserades djupt i självförståelsen, vilket gjorde att ord som slarvig, glömsk och omogen blev till destruktiva sanningar om det egna jaget.

Den skadade självbilden fick negativa konsekvenser som påverkade den dagliga hanterbarheten negativt (Nyström et al., 2020; Rosenthal et al., 2025). I Rowney - Smith et al. (2026) studie manifesterades detta som en genomgripande brist på tillit, både till den egna förmågan att räcka till, i nära relationer och till omgivningens intentioner vilket även visades i studien av Schrevel et al. (2015). Rowney-Smith et al. (2026) visade att återkommande erfarenheter av kritik kunde bidra till en sårad självbild och en förväntan om att bli avvisad eller uppfattad som en belastning i nära relationer. Detta ledde till en ökad vaksamhet inför omgivningens reaktioner och en tendens att anpassa eller dölja delar av sig själv för att uppnå social acceptans som vuxen.

Även om maskering och anpassning kunde minska risken för kritik på kort sikt riskerade de att medföra emotionell utmattning och försvårade utvecklingen av genuina relationer. Detta belyser vikten av att specialistsjuksköterskan i psykiatri bör arbeta med att stärka självacceptans och motverka negativa självföreställningar hos vuxna med ADHD (Rowney-Smith et al., 2026). I arbets-, vardags- och studielivet ledde den låga självbilden ofta till att vuxna använde maskering för att undvika kritik och ifrågasättande. Detta hämmade deltagarna från att anta nya utmaningar och skapade en känsla av att inte kunna använda sin fulla kapacitet.

Liknade resultat visar (Nyström et al., 2020; Schrevel et al., 2015) där maskering dränerade individernas kognitiva och emotionella resurser som behövdes för vardagen samt tvingade vuxna att kompromissa med sin identitet. Maskering verkade ske på bekostnad av det sanna självet då vuxna med ADHD tvingades leva utifrån ett "falskt själv" för att bli accepterad. En tillvaro med denna kroniska press och stress ledde till en mycket hög risk för sekundär psykiatrisk samsjuklighet som depression och ångest (Bjerrum et al., 2017; Nyström et al., 2020). Detta belyser vikten av att specialistsjuksköterskan arbetar med att stärka självacceptans och motverka negativa självföreställningar som etablerats över tid.

Livsförändringar utgjorde särskilt sårbara perioder för vuxna med ADHD. När etablerade rutiner, roller och stödstrukturer förändrades eller försvann försämrades funktionen. Till skillnad från vardagliga utmaningar ställde livsövergångar ökade krav på flexibilitet, planering och självständighet, vilket synliggjorde en sårbarhet som tidigare kunnat kompenseras genom fungerande strategier. Ur ett KASAM-perspektiv kan detta förstås som att både begriplighet och hanterbarhet utmanades när individen ställdes inför nya krav och situationer samtidigt som tidigare erfarenheter och strategier inte längre var tillräckliga.

Konsekvensen riskerade att bli en minskad känsla av kontroll, ökad stress och svårigheter att upprätthålla ett fungerande vardagsliv. Många vuxna med ADHD bar med sig tidigare erfarenheter av misslyckanden och otillräcklighet, vilket riskerade att återaktiveras när de ställdes inför nya eller förändrade livsvillkor. När tidigare kompensatoriska strategier inte längre fungerade kunde känslor av skam, självtvivel och misslyckande återaktualiseras, vilket riskerade att ytterligare försvaga tilltron till den egna förmågan. Detta kan förstås som att ett högt KASAM i vuxenlivet ofta var en skör konstruktion som hölls uppe av omgivningens fasta ramar. När det yttre stödet föll riskerade sammanhanget att bli svårnavigerat (Antonovsky, 2005; Nyström et al., 2020). Detta blev tydligt vid till exempel högre akademiska studier där kraven på självständighet, planering och organisering ökade. Studien av Rosenthal et al. (2025), visade att ett ostrukturerat studentliv försvårade individens förutsägbarhet, vilket gjorde miljön obegriplig och som ledde till att symptom rörande uppmärksamhet och självreglering blev övermäktiga (Rosenthal et al., 2025).

Livshändelser utgjorde därmed ett hot mot hälsan då den upplevda hanterbarheten var otillräcklig, samtidigt som meningsfullheten utmanades vid brytpunkter som skilsmässa eller när barn flyttar ut (Bjerrum et al., 2017; Nyström et al., 2020; Schrevel et al., 2015). Livsövergångar innebar inte enbart risker utan kunde även skapa möjligheter till ny förståelse och personlig utveckling. Om individen erhöll adekvat stöd och gavs möjlighet att utveckla nya strategier kunde förändringen i stället bidra till ökad begriplighet och en mer accepterande självförståelse (Antonovsky, 2005; Nordby et al., 2023).

Detta är särskilt relevant för specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk omvårdnad, då livsövergångar kan betraktas som kliniska riskperioder där behovet av stöd ökar. Genom att uppmärksamma hur förändrade livsvillkor påverkar både självbild och KASAM kan specialistsjuksköterskan arbeta proaktivt med psykoedukation, stödjande samtal och individuellt anpassade strategier för att stärka patientens begriplighet, hanterbarhet och självacceptans (Antonovsky, 2005).

Psykiatriska omvårdnadsinsatser tenderar att vara reaktiva och erbjudas först efter att en kris, skilsmässa eller utmattning är ett faktum (Hansson Halleröd et al., 2015). Utifrån professionens kompetensbeskrivning har specialistsjuksköterskan i psykiatri ett självständigt ansvar att skifta detta arbetssätt mot en proaktiv, förebyggande och långsiktigt hållbar omvårdnad som sträcker sig långt bortom enbart medicinuppföljning (Svensk sjuksköterskeförening, 2024). Genom att använda ett personcentrerat förhållningssätt som

präglas av ovillkorlig positiv aktning, äkthet och empati, skapar specialistsjuksköterskan en trygg och icke dömande allians och relation (Redshaw & McCormack, 2022; Wangel et al., 2024). Specialistsjuksköterskan har en central roll i att stärka individens begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Genom att synliggöra resurser, stödja självacceptans och erbjuda personcentrerade insatser genom livets olika övergångar kan specialistsjuksköterskan bidra till att främja hälsa, stärka individens handlingsförmåga och skapa förutsättningar för ett hållbart liv utifrån egna villkor (Ben-Dor Cohen et al., 2024; Nordby et al., 2023; Svensk sjuksköterskeförening, 2024).

Slutsats

Studien visade att vuxnas erfarenheter av ADHD präglades av en fortgående omförhandling av relationen till den egna personen och omgivningen. Diagnosen kunde bidra till att tidigare erfarenheter blev begripliga, men den kunde samtidigt synliggöra sorg över en historia där svårigheterna länge saknat en förklaring. Vardagen kunde göras hanterbar genom omfattande kompensation, men denna hanterbarhet var inte nödvändigtvis hållbar om den byggde på ständig självkontroll och maskering. Slutligen framträdde meningsfullhet när individen fick möjlighet att använda sina resurser och forma ett liv som var förenligt med de egna förutsättningarna.

En central implikation av resultatet är därför att erfarenheten av att leva med ADHD inte bör förstås enbart utifrån individens svårigheter eller förmåga till anpassning. Resultatet synliggjorde i stället betydelsen av samspelet mellan individ och omgivning. När omgivningen erbjöd förståelse, flexibilitet och relevanta stödstrukturer kunde behovet av kompensation minska och individens egna resurser få större utrymme. KASAM bidrog därmed till att synliggöra hur erfarenheter av ADHD kunde påverka möjligheten att förstå sin livssituation, hantera vardagens krav och skapa ett liv som upplevdes som meningsfullt.

Klinisk tillämpning

Vuxna med ADHD har behov av en personcentrerad, långsiktig och kontinuerlig vård som omfattar både symtomhantering och stöd i vardagslivet utifrån individuella behov och livsvillkor (Becker et al., 2025; Schrevel et al., 2015). Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk omvårdnad har därför en central roll i att främja delaktighet, samordna insatser och skapa en hållbar vårdrelation över tid (Rask et al., 2025). Eftersom vuxna med ADHD ofta beskriver

erfarenheter av otillräckligt stöd och bristande kontinuitet i vården är tillgänglighet, uppföljning och en fast vårdkontakt av särskild betydelse (Björk et al., 2021; Rask et al., 2025).

En trygg och tillitsfull vårdrelation skapar förutsättningar för att uppmärksamma hur ADHD påverkar individens vardagsfunktion, relationer och psykiska välbefinnande (Rask et al., 2025). Genom personcentrerade samtal kan specialistsjuksköterskan bidra till ökad förståelse för den egna funktionsnedsättningen, minska självanklagelser och stödja utvecklingen av mer fungerande strategier för vardagshantering och självreglering (Hansson Halleröd et al., 2015). Regelbundna omvårdnadsbedömningar och uppföljningar kan också möjliggöra tidig identifiering av faktorer som maskering, samsjuklighet, social utsatthet och belastande livshändelser, vilket skapar förutsättningar för förebyggande insatser innan svårigheterna fördjupas (Rosenthal et al., 2025).

KASAM kan användas som ett praktiskt omvårdnadsverktyg för att identifiera och stärka faktorer som påverkar individens upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Genom att öka förståelsen för hur ADHD påverkar vardagen, synliggöra tillgängliga resurser och utgå från individens egna mål kan specialistsjuksköterskan bidra till ökad känsla av sammanhang och stärkt förmåga att hantera livets utmaningar (Antonovsky, 2005).

Social tillhörighet och stödjande relationer för välbefinnande och delaktighet har stor betydelse (Atique et al., 2025; Schrevel et al., 2015). Gruppbaserade insatser och psykoedukation kan minska känslor av ensamhet, öka självförståelsen och skapa möjligheter att dela erfarenheter med andra i liknande situationer (Björk et al., 2021). Samtidigt kan ett familjeorienterat perspektiv stärka stödet från närstående och bidra till ökad förståelse för ADHD i vardagen (Atique et al., 2025; Bjerrum et al., 2017).

Kunskap om ADHD behöver främjas både inom vården och i samhället. Individanpassad psykoedukation kan stärka delaktighet och egenmakt, medan utbildningsinsatser riktade till arbetsgivare, utbildningsinstitutioner och andra samhällsaktörer kan bidra till minskad stigmatisering och ökad inkludering (Hansson Halleröd et al., 2015; Rask et al., 2025; Redshaw & McCormack, 2022). Detta kan skapa bättre förutsättningar för vuxna med ADHD att uppleva delaktighet, självständighet och en god livskvalitet.

Framtida forskning

Vår syntes synliggjorde specifika kunskapsluckor i hur vuxenlivet med ADHD skildras, vilket öppnade upp för nya forskningsområden med direkt relevans för psykiatrisk omvårdnad. Det behövs longitudinella kvalitativa studier som specifikt följer vuxna med ADHD över tid för att undersöka hur normativa och icke-normativa livshändelser påverkar den psykosociala hälsan.

Framtida forskning bör undersöka mekanismerna bakom varför fungerande kompensatoriska strategier plötsligt kollapsar vid miljöbyten samt synliggöra hur åldrande, pensionering och andra livsförändringar påverkar ADHD-relaterade symtom och det psykosociala välbefinnandet. Kulturella aspekters betydelse är en del av den framtida forskningen som behöver synliggöra och belysa hur kulturell kontext, normer och värderingar påverkar vuxnas strategier för maskering, självreglering samt upplevelsen av stigma och sökandet efter psykiatrisk vård. Det behövs studier som kritiskt granskar och utvärderar huruvida dagens diagnoskriterier för ADHD, vilka ursprungligen utgår från och är validerade för barn, är adekvata och giltiga för att identifiera och diagnostisera ADHD i vuxenlivet.

Utvärdering av omvårdnadsledda interventioner: Det krävs interventionsstudier inom psykiatrisk omvårdnad som utvärderar effekten av specialistsjuksköterskeledda, proaktiva stödinsatser som syftar till att bibehålla KASAM under pågående livsförändringar.

Hållbara, etiska och samhälleliga perspektiv

Vuxnas erfarenheter av ADHD formades i samspelet mellan individuella förutsättningar och omgivningens krav. Svårigheterna blev särskilt framträdande när höga krav på planering, självreglering och social anpassning inte motsvarades av tillräckliga stödstrukturer. ADHD behöver förstås i relation till hur vård, arbetsliv och utbildning kan möta olika kognitiva förutsättningar, snarare än enbart som individuella svårigheter (Bisset et al., 2022; Smer, 2026).

Ur ett etiskt perspektiv aktualiserar resultatet frågor om autonomi, värdighet och rättvisa. Erfarenheterna av kritik, missförstånd och utanförskap bidrog till att många dolde sina svårigheter och anpassade sig till omgivningens normer. När individer upplevde behov av att maskera sina svårigheter för att bli accepterade riskerade både autonomi och delaktighet att

begränsas, vilket understryker betydelsen av ett respektfullt och icke-stigmatiserande bemötande (Smer, 2026).

Diagnosen kunde bidra till ökad självförståelse och självacceptans genom att tidigare erfarenheter blev begripliga. En etiskt hållbar vård behöver säkerställa att stöd och insatser utgår från individens faktiska behov och funktionsförmåga, samt att tillgången till vård sker på jämlika villkor (Smer, 2026).

Livshändelser framstod som särskilt sårbara perioder då förändrade krav och rutiner riskerade att öka belastningen och försämra välbefinnandet. Hållbar vård behöver därför vara långsiktig och proaktiv genom att uppmärksamma förändringar i livssituationen och erbjuda stöd innan svårigheterna leder till psykisk ohälsa eller försämrad funktion (Rosenthal et al., 2025; Smer, 2026). Tidiga och samordnade insatser kan förebygga social isolering, svårigheter i arbetslivet och behov av mer omfattande vård, vilket gynnar både individen och samhället (Rosenthal et al., 2025; Smer, 2026).

Specialistsjuksköterskan i psykiatrisk omvårdnad har en viktig roll i att identifiera resurser, stödbehov och hinder i individens omgivning samt stärka delaktighet, autonomi och hälsa. Detta ligger i linje med International Council of Nurses (ICN), som betonar sjuksköterskans ansvar att främja hälsa, värna mänskliga rättigheter och motverka ojämlikhet (ICN, 2022). En etiskt och socialt hållbar vård behöver förena personcentrerad vård med en medvetenhet om omgivningens betydelse. Genom tidiga, samordnade och jämlika insatser kan vården bidra till att vuxna med ADHD ges förutsättningar att vara delaktiga i samhället utan att behöva dölja sina svårigheter eller kompromissa med sin värdighet (ICN, 2022; Smer, 2026).

Självständighet

Härmed intygas ett gemensamt deltagande, ansvar och engagemang genom hela arbetets process. Bakgrund, syfte, problemformulering, metod och diskussion har utformats i samarbete. Under arbetets gång har regelbundna, inplanerade avstämningar genomförts varje vecka. Dessa har innefattat diskussioner kring metod, analys, reflektioner samt planering av det fortsatta arbetet. Sökning av vetenskapliga artiklar och litteratur har genomförts enskilt, med kontinuerligt informationsutbyte där all data delats mellan parterna och varit transparent. Samtliga beslut har fattats gemensamt genom hela studiens olika delar och båda parter har haft ansvar för att överenskommelser och deadlines följts. För språkliga och

grammatiska förbättringar och för viss översättning mellan svenska och engelska språket har Artificiell intelligens (AI) använts som ett stödverktyg i processen.

Referenslista

Inkluderade artiklar för uppsatsens syfte är markerade med *.

American Psychiatric Association (APA). (2026). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. Psychiatry.org - DSM

Antonovsky, A. (2005). *Hälsans mysterium*. Natur & Kultur.

Atique, J., Weerawardhena, H., Climie, E. A., & Callahan, B. L. (2025). Distracted, hyperactive, and thriving: Factors supporting everyday functioning in adults with ADHD. *BMC Psychiatry, 25*(1), Artikel 418. https://doi.org/10.1186/s12888-025-06804-5

*Babinski, D. E., & Libsack, E. J. (2025). Adult diagnosis of ADHD in women: A mixed methods investigation. *Journal of Attention Disorders, 29*(3), 207–219. https://doi.org/10.1177/10870547241297897

Bangma, D. F., Koerts, J., Fuermaier, A. B. M., Mette, C., Zimmermann, M., Toussaint, A. K., Tucha, L., & Tucha, O. (2019). Financial decision-making in adults with ADHD. *Neuropsychology, 33*(8), 1065-1077. https://doi.org/10.1037/neu0000571

*Barnes, A., Denyer, H., Simblett, S., Nordby, E. S., Bilbow, A., Hayashi, W., Hoven, N., Marriott, H., Müller-Sedgwick, U., Rocks, P., Whitwell, S., Larsson, H., Folarin, A., Ramos-Quiroga, J. A., Dobson, R. J. B., & Kuntsi, J. (2026). Perceptions of adults with ADHD on pharmacological treatment initiation and subsequent adherence: A thematic analysis. *Psychiatry Research, 356*, Artikel 116880. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2025.116880

*Beaton, D. M., Sirois, F., & Milne, E. (2022). Experiences of criticism in adults with ADHD: A qualitative study. *PLOS ONE, 17*(2), Artikel e0263366. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263366

Becker, P. H. S., Gunnarsson, A. B., Rask, M., & Safipour, J. (2025). On the way to becoming like anyone else. The experiences of being involved in their care: An interview study with adult patients with ADHD. *Cogent Mental Health, 4*(1), Artikel 2550308. https://doi.org/10.1080/28324765.2025.2550308

*Ben-Dor Cohen, M., Nahum, M., Traub Bar-Ilan, R., Eldar, E., & Maeir, A. (2024). Coping with emotional dysregulation among young adults with ADHD: A mixed-method study of self-awareness and strategies in daily life. *Neuropsychological Rehabilitation, 34*(8), 1161–1185. https://doi.org/10.1080/09602011.2023

Bisset, M., Winter, L., Middeldorp, C. M., Coghill, D., Zendarski, N., Bellgrove, M. A., & Sciberras, E. (2022). Recent attitudes toward ADHD in the broader community: A systematic review. *Journal of Attention Disorders, 26*(4), 537–548. https://doi.org/10.1177/10870547211003671

Bjerrum, M. B., Pedersen, P. U., & Larsen, P. (2017). Living with symptoms of attention deficit hyperactivity disorder in adulthood: A systematic review of qualitative

evidence. *JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, 15*(4), 1080–1153. https://doi.org/10.11124/JBISRIR-2017-003357

Björk, A., Rönngren, Y., Hellzén, O., & Wall, E. (2021). The importance of belonging to a context: A nurse-led lifestyle intervention for adult persons with ADHD. *Issues in Mental Health Nursing, 42*(3), 216–226. https://doi.org/10.1080/01612840.2020.1793247

Brevik, E. J., Lundervold, A. J., Haavik, J., & Posserud, M.-B. (2020). Validity and accuracy of the Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) Self-Report Scale (ASRS) and the Wender Utah Rating Scale (WURS) symptom checklists in discriminating between adults with and without ADHD. *Brain and Behavior, 10*(6), Artikel e01605. https://doi.org/10.1002/brb3.1605

Caldwell, K., Henshaw, L., & Taylor, G. (2011). Developing a framework for critiquing health research: An early evaluation. *Nurse Education Today, 31*, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2010.11.025

Carlberg, M. (2014). *ADHD hos barn och vuxna: Kunskapsstöd för bedömning och behandling* (Rapport 2014-10-40). Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/contentassets/e177b53cd63945438c1d9655057d1cd4/2014-10-40.pdf

Cortese, S., Bellgrove, M. A., Brikell, I., Franke, B., Goodman, D. W., Hartman, C. A., Larsson, H., Levin, F. R., Ostinelli, E. G., Parlatini, V., Ramos- Quiroga, J. A., Sibley, M. H., Tomlinson, A., Wilens, T. E., Wong, I. C. K., Hovén, N., Didier, J., Correll, C. U., Rohde, L. A., & Faraone, S. V. (2025). Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in adults: Evidence base, uncertainties and controversies. *World Psychiatry, 24*(3), 347–371. https://doi.org/10.1002/wps.21374

Faraone, S. V., Banaschewski, T., Coghill, D., Zheng, Y., Biederman, J., Bellgrove, M. A., Newcorn, J. H., Gignac, M., Al Saud, N. M., Manor, I., Rohde, L. A., Yang, L., Cortese, S., Almagor, G., Stein, M. A., Albatti, T., Aljoudi, H. F., Alqahtani, M. M. J., Asherson, P., . . . Wang, Y. (2021). The World Federation of ADHD international consensus statement: 208 evidence-based conclusions about the disorder. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, *128*, 789–818. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.01.022

Ginapp, C. M., Macdonald-Gagnon, G., Angarita, G. A., Bold, K. W., & Potenza, M. N. (2022). The lived experiences of adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: A rapid review of qualitative evidence. *Frontiers in Psychiatry*, *13*, Article 949321. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.949321

Hansson Halleröd, S. L., Anckarsäter, H., Råstam, M., & Hansson Scherman, M. (2015). Experienced consequences of being diagnosed with ADHD as an adult: A qualitative study. *BMC Psychiatry, 15,* Artikel 31. https://doi.org/10.1186/s12888-015-0410-4

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Socialdepartementet. Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) | Sveriges riksdag

International Council of Nurses. (2022). *ICN:s etiska kod för sjuksköterskor*. Svensk sjuksköterskeförening.

https://swenurse.se/download/18.7104a0bd181fce0092f0132/1656659417909/A4%20ICN%20Etiska%20kod%20enkelsidor.pdf

Koerts, J., Bangma, D. F., Mette, C., Tucha, L., & Tucha, O. (2023). Strengths and weaknesses of everyday financial knowledge and judgment skills of adults with ADHD. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 20*(5), Artikel 4656. https://doi.org/10.3390/ijerph20054656

Kooij, J. J. S., Bijlenga, D., Salerno, L., Jaeschke, R., Bitter, I., Balázs, J., Thome, J., Dom, G., Kasper, S., Nunes Filipe, C., Stes, S., Mohr, P., Leppämäki, S., Casas, M., Bobes, J., McCarthy, J. M., Richarte, V., Kjems Philipsen, A., Pehlivanidis, A., … Asherson, P. (2019). Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD. *European Psychiatry, 56*, 14–34. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2018.11.001

Kwame, A., & Petrucka, P. M. (2021). A literature-based study of patient-centered care and communication in nurse-patient interactions: Barriers, facilitators, and the way forward. *BMC Nursing, 20*, Artikel 158. https://doi.org/10.1186/s12912-021-00684-2

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Utbildningsdepartementet. Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor | Sveriges riksdag

Lange, K. W., Reichl, S., Lange, K. M., Tucha, L., & Tucha, O. (2010). The history of attention deficit hyperactivity disorder. *Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 2*(4), 241–255. https://doi.org/10.1007/s12402-010-0045-8

Löfberg, A. (2022). Abduktion som kunskapsfilosofi och forskningsmetod. *Pedagogisk Forskning i Sverige, 27*(4), 17–36. https://doi.org/10.15626/pfs27.04.02

*Maeir, T., Tzionit, N., Shalev, N., & Landau, A. N. (2026). Assessing functional cognition in adult students with attention-deficit/hyperactivity disorder using the Daily Living Questionnaire. *Disability and Rehabilitation, 48*(11), 3395–3404. https://doi.org/10.1080/09638288.2025.2575870

*Michielsen, M., de Kruif, J. T. C. M., Comijs, H. C., van Mierlo, S., Semeijn, E. J., Beekman, A. T. F., Deeg, D. J. H., & Kooij, J. J. S. (2018). The burden of ADHD in older adults: A qualitative study. *Journal of Attention Disorders, 22*(6), 591–600. https://doi.org/10.1177/1087054715610001

*Nordby, E. S., Guribye, F., Nordgreen, T., & Lundervold, A. J. (2023). Silver linings of ADHD: A thematic analysis of adults' positive experiences with living with ADHD. *BMJ Open, 13*, Artikel e072052. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-072052

Nyström, A., Petersson, K., & Janlöv, A.-C. (2020). Being different but striving to seem normal: The lived experiences of people aged 50+ with ADHD. *Issues in Mental Health Nursing, 41*(6), 476–485. https://doi.org/10.1080/01612840.2019.1695029

*Paley, T., Maeir, A., & Shor, R. (2025). Change-promoting processes in occupational recovery among adults with ADHD. *Occupational Therapy in Mental Health, 41*(3), 379–395. https://doi.org/10.1080/0164212X.2024.2420363

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (11 uppl.). Wolters Kluwer.

Rask, M., Rytterström, P., Sellin, T., Lundqvist, L.-O., Schröder, A., & Brunt, D. (2025). The relationship between staff and patient interactions and patients' perceptions of good quality of care in psychiatric outpatient services: A structural equation model. *Scandinavian Journal of Caring Sciences, 39*(2), Artikel e70043. https://doi.org/10.1111/scs.70043

Redshaw, R., & McCormack, L. (2022). Being ADHD: A qualitative study. *Advances in Neurodevelopmental Disorders, 6*, 20-28. https://doi.org/10.1007/s41252-021-00227-5

Region Stockholm. (oktober 2025). *ADHD. Kunskapsstöd för vårdgivare*. Adhd - Kunskapsstöd för vårdgivare

Region Stockholm. (u.å). *Diagnoskriterier för adhd.* Diagnoskriterier för adhd

Riksförbundet Attention. (2026). *ADHD*. ADHD - Riksförbundet Attention

Ryttersund, A., Sjögran, L., & Englander, M. (2020). Återhämtning från psykisk ohälsa i en professionell psykiatrisk omvårdnadskontext - en fenomenologisk studie. *Socialmedicinsk tidskrift 97*(2), 303–313. https://doi.org/10.62607/smt.v97i2.38408

Rosenthal, E. A., Mitchell, J. T., Weisner, T. S., Silverstein, N., Yi, C., Arnold, L. E., Hechtman, L. T., Hinshaw, S. P., & Jensen, P. S. (2025). What can adults with ADHD tell us about their experiences? A review of qualitative methods to map a new research agenda. *Journal of Attention Disorders, 29*(13), 1190-1212. https://doi.org/10.1177/10870547251352589

Rowney-Smith, A., Sutton, B., Quadt, L., & Eccles, J. A. (2026). The lived experience of rejection sensitivity in ADHD - A qualitative exploration. *PLoS One, 21*(1), Article e0314669. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0345112

Schrevel, S. J. C., Dedding, C., van Aken, J. A., & Broerse, J. E. W. (2015). Do I need to become someone else? A qualitative exploratory study into the experiences and needs of adults with ADHD. *Health Expectations, 19*(1), 39–48. https://doi.org/10.1111/hex.12328

*Schreuer, N., & Dorot, R. (2017). Experiences of employed women with attention deficit hyperactive disorder: A phenomenological study. *Work, 56*(3), 429–441. https://doi.org/10.3233/WOR-172509

Skoglund, C., Sundström Poromaa, I., Leksell, D., Ekholm Selling, K., Cars, T., Giacobini, M., Young, S., & Kopp Kallner, H. (2024). Time after time: Failure to identify and support females with ADHD – A Swedish population register study. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 65*(6), 832–844. https://doi.org/10.1111/jcpp.13920

Socialstyrelsen. (2019). *Konsekvenser för vuxna med diagnosen ADHD: Kartläggning och analys* (Artikelnummer 2019-6-21).

https://www.socialstyrelsen.se/contentassets/567623a62a08423d82e4e0ebaedc19c0/2019-6-21.pdf

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2025). *Bilaga 3. PRISMA flödesschema*. https://www.sbu.se/contentassets/de3a9007ceca479faa7a7373ad9a32a0/bilaga-3.-prisma-flodesscheman.pdf

Statens medicinsk-etiska råd. (2026). *Aktuella etiska aspekter på ADHD* (Smer 2026:4). https://smer.se/wp-content/uploads/2026/06/yttrande-aktuella-etiska-aspekter-pa-ADHD.pdf

Svensk sjuksköterskeförening. (2024). *Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård.* https://swenurse.se/download/18.ad7ce2419367d798a21bc8a/1732866911290/Kompetensbeskri vning%20psykiatri%202024.pdf

Tal, L., & Goodman, Y. C. (2023). For me, "normality" is not normal: Rethinking medical and cultural ideas of midlife ADHD diagnosis. *Culture, Medicine, and Psychiatry, 49*, 183–204. https://doi.org/10.1007/s11013-023-09825-5

Vetenskapsrådet (23 september 2024). *God forskningssed 2024.* https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2024-10-02-god-forskningssed-2024.html

Wang, C., Hou, L., Zhou, H., Wang, Q., Yan, H., Lang, Y., Tan, J., Liu, Y., Ge, Y., Lin, Y., Fu, C., & Liu, J. (2025). The evolving global burden of ADHD: A comprehensive analysis and future projections (1990–2046). *Journal of Affective Disorders, 391*, Artikel 120037. https://doi.org/10.1016/j.jad.2025.120037

Wangel, A. M., Persson, K., Duerlund, S., Fhager, J., Mårdhed, E., Sjögran, L., Sjöström, K., Glantz, A., Örmon, K., & Sunnqvist, C. (2024). The core elements of psychiatric and mental health nursing: Time, honest engagement, therapeutic relations, professional nursing and lifetime- perspective. *Issues in mental health nursing, 45*(4), 399- 408. https://doi.org/10.1080/01612840.2024.2305934

Ward, J., McBride, A., Gudka, R., Becker, K., Newlove-Delgado, T., & Price, A. (2024). Wider health needs in attention deficit hyperactivity disorder from lived and professional experience: A qualitative framework analysis. *BMJ Open, 14,* Artikel e083539. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-083539

Watters, C., Adamis, D., McNicholas, F., & Gavin, B. (2018). The impact of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adulthood: A qualitative study. *Irish Journal of Psychological Medicine, 35*(3), 173–179. https://doi.org/10.1017/ipm.2017.21

Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. *Journal of Advanced Nursing, 52*(5), 546–553. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x

Wiklund Gustin, L. (Red.). (2024). *Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå.* Studentlitteratur.

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2016*). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet* (3 uppl.). Studentlitteratur.

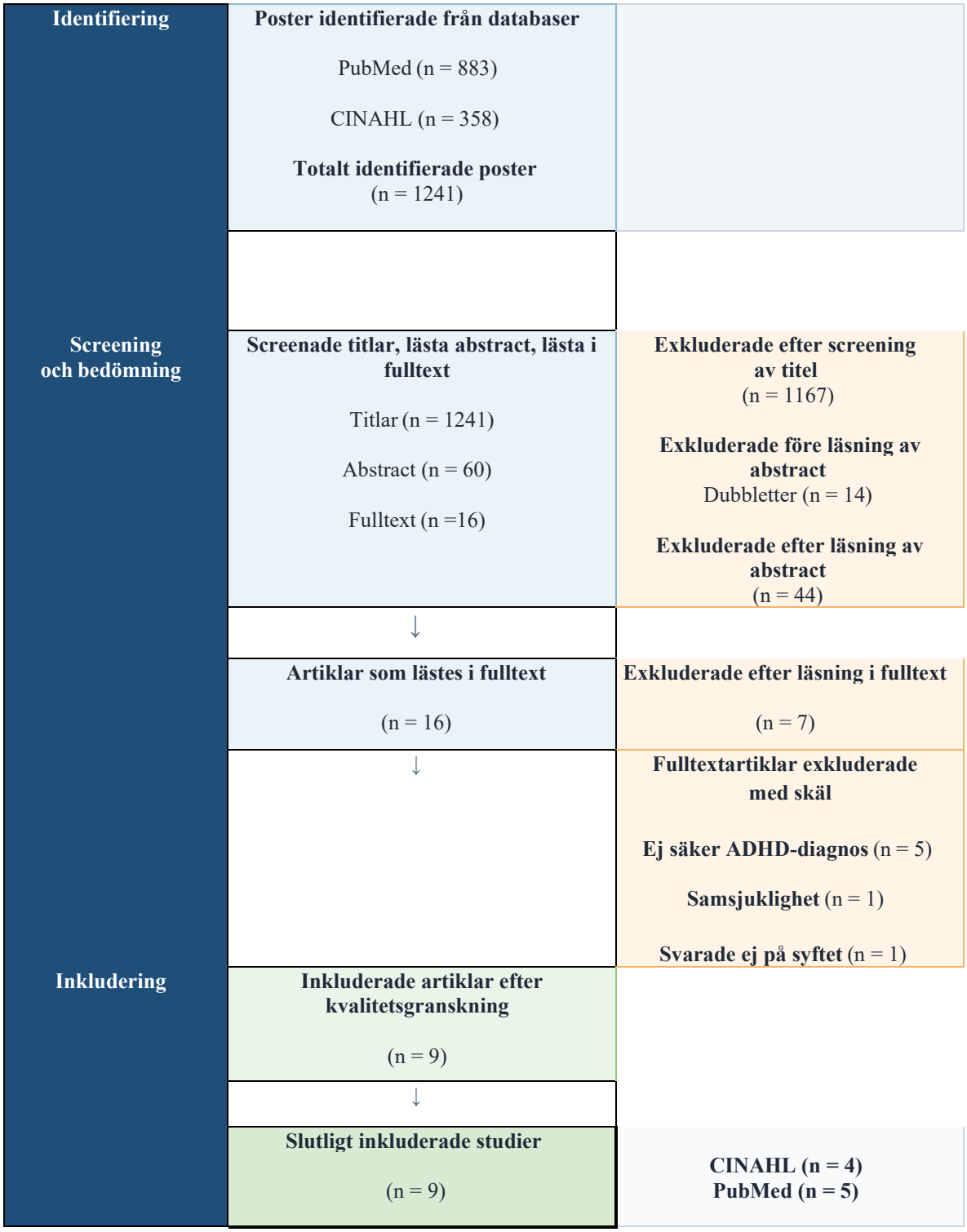
Bilaga 1a. Databassökning i CINAHL.

CINAHL Ämnesord	Sökningar Filter: 10 år, engelska, all adults, vetenskaplig tidskrift		Sökträffar	Screenade Titlar	Lästa Abstract	Lästa i Fulltext	Valda artiklar	Kvalitets-granskade
ADHD	S1	MH "Attention Deficit Hyperactivity Disorder"	1862	0	0	0		
	S2	ADHD OR "attention deficit hyperactivity disorder"	2058	0	0	0		
	S3	S1 OR S2	2058	0	0	0		
Vuxen	S4	MH "Adult+" OR MH "Young Adult" OR MH "Middle Age" OR MH "Aged+" OR (MH "Aged, 80 and Over+")	865 13	0	0	0		
	S5	Adult*	605 222	0	0	0		
	S6	S4 OR S5	825 447	0	0	0		
Erfarenhet	S7	MH "Life Experiences+"	9931	0	0	0		
	S8	Life experience* OR experience* OR “lived experience* OR “daily life” OR “daily living OR “everyday life”	136 969	0	0	0		
	S9	S7 OR S8	136 969	0	0	0		
Datum för Slutsökning: **20260725**	S10	S3 AND S6 AND S9	**358**	**358**	**11**	**6**	**4**	**4**

Bilaga 1b. Databassökning i PubMed.

PubMed Ämnesord	Sökningar Filter: 10 år, engelska, +19 år		Sökträffar	Screenade Titlar	Lästa Abstract	Lästa Fulltext	Valda Artiklar	Kvalitets-granskade
ADHD	S1	"Attention Deficit Disorder with Hyperactivity"[Mesh]	4848	0	0	0		
	S2	(ADHD[Title/Abstract]) OR ("attention deficit hyperactivity disorder"[Title/Abstract])	5953	0	0	0		
	S3	S1 OR S2	6186	0	0	0		
Vuxen	S4	((((("Adult"[Mesh]) OR "Young Adult"[Mesh]) OR "Middle Aged"[Mesh]) OR "Aged" [Mesh]) OR "Aged, 80 and over"[Mesh]	2 531 455	0	0	0		
	S5	adult*[Title/Abstract]	521 923	0	0	0		
	S6	S4 OR S5	2 530 611	0	0	0		
Erfarenhet	S7	"Life Change Events"[Mesh]	2163	0	0			
	S8	("life experience*"[Title/Abstract] OR "experience*"[Title/Abstract] OR "daily life"[Title/Abstract] OR "daily living [Title/Abstract] OR "lived experience*"[Title/Abstract] OR "everyday life"[Title/Abstract])	317 808	0	0	0		
	S9	S7 OR S8	318 788	0	0	0		
Datum för Slutsökning: **20260725**	S10	S3 AND S6 AND S9	883	883	49	10	5	5

Bilaga 2. Flödesschema.

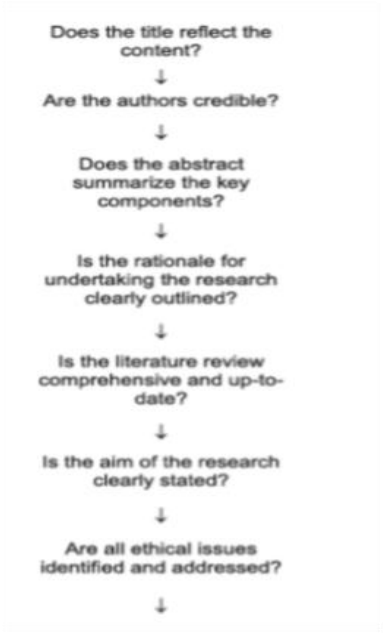


Bilaga 3. Matris för kvalitetsgranskning av artiklar.

Artikel	Design och urval	Styrkor	Begränsningar/bias	Kvalitet
Babinski & Libsack (2025)	Mix metod. 14 kvinnor diagnostiserade med ADHD i vuxen ålder. ASRS. Fokusgrupper och kvantitativa skattningar online.	Tydligt syfte, etiskt godkänd, verifierade ADHD-symtom/ funktionsnedsättning (2 områden) + ASRS. IPA-analys, två kodare och integrering av kvalitativa och kvantitativa data.	Litet urval, samsjuklighet. Ingen member checking. Begränsad överförbarhet. Depression, ångest, PTSD	**Hög**
Barnes et al. (2026)	Kvalitativ studie. 25 vuxna med ADHD intervjuades cirka ett år efter läkemedelsstart. Semistrukturerade intervjuer och induktiv tematisk analys.	Tydligt syfte, DSM-5-diagnos, tydliga inklusions- och exklusionskriterier. Etiskt godkänd, datamättnad, flera kodare, NVivo och reflexivitet.	Endast deltagare som fullföljt studien i 12 månader och valt intervju. Redogör ej för bortfallet. Främst UK-urval, flera bodde i städer.	**Hög**
Beaton et al. (2022)	Kvalitativ studie. 162 vuxna med ADHD/höga ADHD-drag. ASRS. Öppen fritextfråga och tematisk analys.	Delvis självrapporterad diagnos +ASRS. Tydligt syfte, relevant kvalitativ metod, transparent analys, forskarreflexivitet och citat. Etiskt godkänd.	Endast en öppen fråga. Ingen fördjupande intervju, följdfrågor eller member checking. Självrapporterad samsjuklighet exkluderades.	**Medel-hög**
Ben-Dor Cohen et al. (2024)	Mix metod-design. 60 unga vuxna med ADHD. SRSI-intervjuer, ASRS och EMA under fem dagar.	Tydlig mixad metod. Verifierad ADHD + ASRS. Flera datakällor, systematisk analys, etiskt godkänd och tydlig integrering av fynd.	Litet urval. Unga vuxna. Ingen kontrollgrupp. Självrapporterad samsjuklighet exkluderades.	**Hög**
Maeir et al. (2026)	Kvantitativ tvärsnittsstudie. 64 universitetsstudenter. ADHD-grupp och kontrollgrupp. ASRS.	Formell ADHD-diagnos + ASRS. Anamnesupptagning för samsjuklighet. Etiskt godkänd. Kontrollgrupp, validerade instrument, hög reliabilitet och relevanta statistiska analyser.	Litet och selekterat urval. Självskattning av samsjuklighet. Medicinering och substansbruk kontrollerades inte.	**Hög**
Michielsen et al. (2018)	Kvalitativ intervjustudie. 17 äldre vuxna >65 år från tidigare studie med forskning av ADHD. DSM och DIVA 2.0	Djupintervjuer, tydlig rekrytering, DIVA/DSM-kriterier. Tydlig tematisk analys, mättnad och member checking.	Litet och etniskt homogent urval. Oklar psykiatrisk samsjuklighet. Recall bias. Etiskt godkänd.	**Hög**
Nordby et al. (2023)	Kvalitativ enkätstudie. 50 vuxna med ADHD (uppgav klinik och läkare som diagnostiserat) Internetbaserad intervention. Tematisk analys.	Tydligt syfte, etiskt godkänd, relativt stort kvalitativt urval, transparent analys och reflexivitet.	**En** öppen fråga, korta svar. Ej följdfrågor. Intervention och givna exempel kan ha påverkat svaren. Kvinnodominerat urval.	**Medel-hög**
Paley et al. (2025)	Kvalitativ intervjustudie. 30 vuxna med ADHD och upplevda yrkes-/aktivitetsförändringar. ASRS (uppgav neurolog/psykiater som diagnostiserat)	Formell ADHD-diagnos + ASRS, djupintervjuer, fenomenologisk ansats, systematisk analys och citat. Etiskt godkänd.	Strategiskt selekterat urval. Sociala medier. Högutbildade/yrkes-verksamma dominerar. Självrapporterad samsjuklighet (ingen påverkan på funktion).	**Hög**
Schreuer & Dorot (2017)	Kvalitativ fenomenologisk studie. 11 yrkesverksamma kvinnor som medicinerade för ADHD.	Dokumenterad ADHD-diagnos. Djupintervjuer, triangulering, reflektionsanteckningar,	Litet urval. Endast högutbildade arbetande kvinnor. Rekrytering via annonser/sociala medier. Begränsad överförbarhet.	**Hög**

	Dokumenterad diagnos från psykiater/neurolog)	member checking och rik resultatredovisning. Etiskt godkänd.		

Bilaga 4. Granskningsmall.





Bilaga 5. Artikelöversikt.

Författare, år, land	Syfte	Metod/design	Urval (ålder, kön, n)	Datainsamling	Huvudresultat	Kvalitetsbedömning
Babinski & Libsack (2025), USA	Undersöka kvinnors erfarenheter av vuxendiagnostiserad ADHD samt hinder/faciliatorer för diagnos och behandling.	Mixed methods; 2 virtuella fokusgrupper; IPA + enkla skattningar.	n=14 kvinnor, 31-52 år, M=39,43; vuxendiagnos; ASRS + funktionsskattning; hög samsjuklighet främst ångest/depression.	Zoomfokusgrupper ca 2 h om diagnosens betydelse, svårigheter att få diagnos och om livet blev bättre/svårare.	Validering, lättnad, självförståelse, självmedkänsla, behandling och socialt stöd. Samtidigt stigma, vårdhinder, behandlingsbörda och erfarenheter av lathet/otillräcklighet/annorlundaskap.	Hög; tydligt syfte, relevant analys, rika citat. Begränsning; litet självselekterat kvinnourval. Etiskt godkänd.
Barnes et al. (2026), GB	Undersöka vuxnas erfarenheter första året efter farmakologisk ADHD-behandling och påverkan på följsamhet/avbrott.	Kvalitativ intervjustudie; semistrukturerade intervjuer; induktiv tematisk analys.	n=25 vuxna med DSM-5 ADHD; 23-57 år, M=39; 14 kvinnor/11 män; fullföljt ART-CARMA; exkl. psykos, drogberoende, aktuell depression, mani, neurologisk sjukdom.	Microsoft Teams-intervjuer 2023-2024; 24-60 min, M=44; frågor om diagnos, behandlingsstart, titrering, effekt, följsamhet och avbrott.	Teman: diagnosbearbetning, förväntningar, stöd, nyttja/acceptera. Medicinering kunde förbättra symtom, men biverkningar och otillräckligt stöd påverkade följsamhet.	Hög; klinisk relevant, DSM-5-verifierad ADHD, varierat urval, tydlig analys. Begränsning; endast fullföljare intervjuades. Etiskt godkänd.
Beaton, Sirois & Milne (2022), GB	Fördjupa förståelsen för hur vuxna med ADHD/höga ADHD-drag upplever kritik från närmiljön.	Kvalitativ fritextstudie från större online-studie; induktiv tematisk analys i NVivo.	n=162; 18-62 år, M=33,80; 109 kvinnor, 52 män, 1 annan; 96 självrapporterad ADHD-diagnos, 66 höga ASRS-drag; samsjuklighet exkluderad.	Anonym öppen frienutfråga om kritik från familj, vänner och kollegor.	Fem teman: vad som kritiserades, vad som uppfattades som kritik, konsekvenser, coping och stöd förståelse. Kritik rörde organisation, tid, glömska, fokus och impulsivitet; påverkade självkänsla och välbefinnande.	Medelhög; stort material och tydlig analys. Begränsning: en frienutfråga, inga följdfrågor, självrapporterad diagnos/samsjuklighet. Etiskt godkänd.
Ben-Dor Cohen et al. (2024), Israel	Utforska självmedveten och strategier vid emotionell dysreglering samt samband med ADHD-symtom.	Mixed methods; kvantitativ tvärsnitt/EMA + kvalitativ riktad tematisk analys.	n=60 unga vuxna; 18-33 år, M=24,62; 32 kvinnor/28 män; medicinsk ADHD-diagnos + ASRS över gräns; psykiatrisk/neurologisk samsjuklighet exkl. via självrapport.	SRSI, ASRS och EMA 5 dagar, 5 ggr/dag; kvalitativt urval av 13 intervjuer.	Svårigheter med självmedvetenhet och strategier. Teman: uppenbarsamma känslosignaler, identifiera triggers och arbeta med sig själv. Strategier var ansträngningskrävande och kontextberoende.	Hög; validerade instrument, EMA, COREQ. Begränsning: ingen kontrollgrupp, ungt urval, exklusion baserad på självrapport. Etiskt godkänd.
Macit, Tzionit, Shalev & Landau (2026), Israel	Utvärdera DLQ för funktionell kognition hos studenter med ADHD och samband med ADHD-symtom/emotionell belastning.	Kvantitativ tvärsnittsstudie med gruppjämförelser.	n=64 studenter; ADHD n=37, kontroll n=27; ADHD M=24,65 år, kontroll M=25,33; ADHD: 17 män/20 kvinnor, formell diagnos av neurolog/psykiater.	Självskattningar: DLQ, ASRS och DASS-21.	ADHD-gruppen skattade större funktionella kognitiva svårigheter i alla DLQ-subskalor. DLQ särskilde grupperna med 75 % träffsäkerhet. ADHD-symtom förklarade 42 % av varansen; distress ej signifikant.	Hög; verifierad diagnos, validerade instrument, tydliga analyser. Begränsning: tvärsnitt, studenturval, okontrollerad medicinering. Etiskt godkänd.

Författare, år, land	Syfte	Metod/design	Urval (ålder, kön, n)	Datainsamling	Huvudresultat	Kvalitetsbedömning
Michielsen et al. (2018), Nederländerna	Utforska hur ADHD påverkat äldre vuxnas liv utan diagnosmedvetenhet och om symtom förändrats över livsloppet.	Kvalitativ intervjustudie; tematisk analys; LASA-urval.	n=17; >65 år; 67-69 (n=6), 73-75 (n=5), 76-86 (n=6); 7 män/10 kvinnor; ADHD fastställd med DIVA 2.0 och barndoms/aktuella symtom.	Djupintervjuer i hemmet 90-150 min; transkribering, analys och member checks.	Sju teman: aktiv, impulsiv, uppmärksamhetssvårigheter, mental rastlöshet, låg självkänsla, överskrida gränser, känna sig missförstådd. Livslånga svårigheter och sen förståelse.	Hög; diagnostisk bedömning, rika intervjuer, mättnad/member checks. Begränsning: litet homogent urval, okänd psykiatrisk samsjuklighet.
Nordby et al. (2023), Norge	Identifiera positiva aspekter av ADHD och bidra till styrkebaserad förståelse.	Kvalitativ enkätstudie; fritextsvar; tematisk analys inom hermeneutisk fenomenologisk ram.	n=50 vuxna med ADHD; M=34 år; 44 kvinnor/6 män; majoritet vuxendiagnostiserade; 38 (76 %) daglig ADHD-medicin.	Skriftliga svar på öppen fråga i internetbaserad intervention; analys i NVivo enligt Braun & Clarke.	Fyra teman: ADHD-dragens dubbla påverkan, okonventionellt tänkande, sökande efter nya erfarenheter samt resiliens/personlig utveckling. ADHD sågs som både utmaning och styrka beroende på kontext.	Medelhög; tydligt syfte, relevant metod, relativt stort urval, reflexivitet. Begränsning: positiv-fråga, majoritet kvinnor, intervention kan ha påverkat. Etiskt godkänd.
Paley, Maeir & Shor (2025), Israel	Identifiera processer som främjar aktivitetsrelaterad återhämtning hos vuxna med ADHD.	Kvalitativ studie; semistrukturerade narrativa intervjuer; fenomenologisk epistemologi och tematisk innehållsanalys.	n=30; 28-58 år, M=40,6; 24 kvinnor/6 män; diagnos av neurolog/psykiater; 29 arbetade; 24 hade/pågick akademisk examen; 22 föräldrar; 25 i relation.	ASRS och modifierad OPHI-II; intervjuer 60-90 min, ljudinspelade/transkriberade; fokus på aktivitetsval, roller, rutiner, livshändelser, miljöer och hälsa.	Tre teman: aktivitetsglapp, aktivitetsval och reglering av aktivitetsansträngning. Glapp mellan intention/resultat omtolkades efter diagnos; kunskap, stöd, strategier och meningsfulla val främjade förändring.	Hög; verifierad diagnos, etablerat intervjuprotokoll, mättnad och konsensusanalys. Begränsning: sociala medier-urval, högfungerande deltagare, retrospektiva berättelser. Etiskt godkänd.
Schreuer & Dorot (2017), Israel	Utforska erfarenheter hos yrkesverksamma kvinnor med ADHD och anpassningar som underlättar arbete.	Kvalitativ fenomenologisk studie; djupintervjuer; tematisk innehållsanalys.	n=11 kvinnor; 25-45 år, M=33,5; dokumenterad diagnos från neurolog/psykiater; eftergymnasial utbildning; yrken inom undervisning, socialt arbete, vård, design, kemiteknik, administration.	Semistrukturerade djupintervjuer ca 2 h av arbetsterapeut; ljudinspelning, transkribering, fältanteckningar, analys av tre forskare och deltagarvalidering.	Tre arbetsrelaterade teman: arbetskrav/miljö, copingstrategier och anpassningar. Svårigheter med stimuli, känsloreglering, tid, gränser, sociala koder och diagnosöppenhet. Strategier: medicin, pauser, listor, teknik, tyst miljö, flexibilitet, mentorskap och kollegialt stöd.	Hög; verifierad diagnos, djupa intervjuer, triangulering, mättnad, deltagarvalidering. Begränsning: litet kvinnligt, yrkesverksamt, högutbildat urval. Etiskt godkänd.

Bilaga 6. Jämförelsematris.

Studie, År & Land	Ålder & Deltagare	ADHD-diagnos	Exklusionskriterier	Rekrytering, Metod & Design	Centrala resultat
Babinski & Libsack (2025) **USA**	Ålder: 31 - 52 M= 40 år Antal: 14 kvinnor	ADHD-diagnos i vuxen ålder. ASRS och funktions-skattning.	Exkluderades om funktionsnedsättning inte uppfylldes inom två områden samt vid bipolär sjukdom, AST, schizofreni eller andra psykotiska tillstånd.	Rekrytering via sociala medier. Mixad metod med två digitala fokusgrupper via Zoom samt online-formulär. ASRS, funktionsskattning och ja/nej/osäker-frågor som kompletterade fokusgrupperna.	Diagnosen beskrevs: -validerande -gav förklaring -gav självmedkänsla -tillgång till behandling och stöd Framkom hinder i diagnostik, vård, stigma Egen drivkraft Svårigheterna kunde maskeras av ångest, trauma. depression eller hög prestation
Barnes et al. (2026) **GB**	Ålder; 23 - 57 M=39 år Antal: 25 (11 män, 14 kvinnor)	ADHD-diagnos fastställd i tidigare ART-CARMA-studie.	Drogberoende, psykotiska symtom, pågående egentlig depression, mani eller neurologisk sjukdom vid studiestart eller de senaste 6 månaderna.	Rekrytering via offentliga ADHD-kliniker och psykiatriska mottagningar. Kvalitativa intervjuer inom ART-CARMA under första året efter läkemedelsstart. Induktiv tematisk analys. NVivo 14 användes för kodning.	Läkemedelserfarenheter formades av diagnosbearbetning, stöd från vården och förväntningar. Följsamhet eller avbrott påverkades av balansen mellan nytta, biverkningar, reboundeffekt, påverkan på arbete och vardag samt önskemål om icke farmakologiskt stöd.
Beaton et al. (2022) **GB**	Ålder:18 - 62 M= 34 år Antal:162 (52 män, 109 kvinnor, 1 annat kön)	ADHD eller höga ADHD- drag. ASRS över gränsvärde.	Självrapporterad samsjuklighet som OCD, AST, affektiva tillstånd, bipolär sjukdom, bete ende- eller personlighets-relaterade tillstånd. Fritextsvar under 10 ord exkluderades.	Rekrytering via ADHD-forum, sociala medier, offentliga anslag och universitetsstöd. Kvalitativ fritextstudie med öppna anonyma webbenkätsvar. Induktiv tematisk analys i NVivo 12.	Återkommande kritik kopplades till glömska, ouppmärksamhet, tid, impulsivitet och sociala situationer. Kritiken påverkade självkänsla, självbild och välbefinnande. Coping handlade om att dölja svårigheter, förändra omgivningen, acceptera sig själv eller söka förståelse.
Ben-Dor Cohen et al. (2024) **Israel**	Ålder:18 - 33 M=25 år Antal: 60 (32 kvinnor, 28 män)	Själv-rapporterad ADHD-diagnos. ASRS över gräns-värde.	Självrapporterad psykiatrisk samsjuklighet eller annat större hälsotillstånd. ASRS under gränsvärde.	Rekrytering via sociala medier och studentorganisationer. Mixad metod med fysiska semistrukturerade intervjuer. SRSI och EMA via mobilapp under 5 dagar. Tematisk analys och riktad innehållsanalys.	Emotionell dysreglering hanterades genom självmedvetenhet, självreglering och kompensatoriska strategier. Deltagarna beskrev både medvetna strategier och svårigheter att upprätthålla reglering i komplexa situationer.
Maeir et al. (2026) **Israel**	M=25 år Antal: 64 studenter (37 med ADHD, 27 i kontroll-grupp)	Formell ADHD-diagnos ställd av neurolog /psykiater enligt israelisk klinisk praxis.	Tidigare eller aktuell större psykiatrisk eller neurologisk sjukdom.	Rekrytering via universitetets webbplattform för forskningsdeltagande. Kvantitativ tvärsnittsstudie med DLQ, ASRS och DAS-21.	Studenter med ADHD rapporterade större funktionella kognitiva svårigheter än kontroll-gruppen inom nästan alla DLQ-områden. Svårigheterna gällde särskilt planering, organisering, minne, att återuppta aktiviteter efter avbrott, komplexa uppgifter och filtrering av irrelevanta stimuli.
Michielsen et al. (2018) **NL**	Ålder: 67 - 86 Antal: 17 (10 kvinnor, 7 män)	Forskarna diagnostiserade deltagarna med ADHD med DSM och DIVA, men informerade inte deltagarna.	Inga specifika exklusionskriterier rapporterades. Deltagarna identifierades genom LASA:s ADHD-diagnostiska procedur.	Rekrytering från Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). Kvalitativa djupintervjuer i hemmet, 90–150 minuter. Tematisk analys.	ADHD beskrevs som livslång belastning med påverkan på skolgång, arbete, relationer, självkänsla och känslan av att vara missförstådd. Symtomen kvarstod i äldre ålder men upplevdes delvis förändrade genom minskade krav efter pensionering och utvecklade strategier.
Nordby et al. (2023) **Norge**	M= 34 år Antal: 50 (44 kvinnor, 6 män)	ADHD-diagnos bekräftades genom uppgifter om läkare, mottagning och diagnos-datum i tel.-intervju med klinisk	Svår depression, suicidala tillstånd, bipolär sjukdom, psykos, substansbruk eller pågående psykologisk behandling.	Rekrytering via norska ADHD-föreningens facebooksida och e-postlistor. Kvalitativ enkätstudie med skriftliga fritextsvar på 1 öppen fråga. Tematisk analys med hermeneutisk-fenomenologisk ansats. NVivo användes.	Deltagarna beskrev ADHD som både utmaning och resurs beroende på kontext. Positiva aspekter var energi, hyperfokus, kreativitet, nytänkande, mod, empati och nyfikenhet. Motgångar kunde bidra ti ll resiliens, självacceptans och

		psykolog eller sjuk-sköterska.	Samsjuklighet screenades med MINI.		personlig utveckling.
Paley et al. (2025) **Israel**	Ålder: 28 - 58 M=40 år Antal: 30 (24 kvinnor, 6 män)	Tidigare ADHD-diagnos ställd av neurolog eller psykiater. ASRS användes för aktuell symtomnivå.	Självrapporterad sjukersättning på grund av betydande funktions-nedsättning eller annan sjukdom än ADHD som påverkade vardagsfungerandet.	Ändamålsenligt urval via ADHD-relaterade sociala medier. Deltagarna skulle ha upplevt förändringar i aktivitets- och vardagserfarenheter. Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer 60–90 minuter på lugn plats. Fenomenologisk ansats.	Deltagarna beskrev aktivitetsgap där intentioner inte motsvarade utfall, vilket skapade stress och låg självtillit. Diagnos, insikt, kunskap och strategier bidrog till förändrade yrkesval, bättre reglering av ansträngning och ökad förmåga att välja aktiviteter utifrån intresse, värderingar och styrkor.
Schreuer & Dorot (2017) **Israel**	Ålder: 25 - 45 M=33 år Antal: 11 kvinnor (Högutbildade och yrkes-arbetande)	Dokument-erad ADHD-diagnos ställd av neurolog eller psykiater.	Annan självrapporterad funktionsnedsättning eller hälsoproblematik exkluderades för att minska påverkan av samsjuklighet.	Rekrytering via professionella webbplatser, forum, e-post och Facebook. Kvalitativ fenomenologis studie med djupintervjuer cirka två timmar. Fenomenologisk temat isk analys genomförd av tre forskare.	Arbetslivet beskrevs som viktigt för identitet och självbild men samtidigt krävande. Svårigheter gällde sensorisk belastning, emotionell reglering, tidsuppfattning, gränssättning, sociala koder och balans mellan struktur och flexibilitet. Personliga strategier, arbetsplatsanpassningar, stöd och förståelse efterfrågades.